UNIFACS – UNIVERSIDADE SALVADOR
CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

ALBERT AELCIO DIAS DA SILVA
HUGO FERREIRA DOS REIS
JOILSON MOURA DOS SANTOS FORTUNA

USO DE ESTEROIDES ANABOLIZANTES POR PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO E O PAPEL DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA: ENTRE A ORIENTAÇÃO E A CONIVÊNCIA

Salvador
2026

ALBERT AELCIO DIAS DA SILVA
HUGO FERREIRA DOS REIS
JOILSON MOURA DOS SANTOS FORTUNA

USO DE ESTEROIDES ANABOLIZANTES POR PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO E O PAPEL DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA: ENTRE A ORIENTAÇÃO E A CONIVÊNCIA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Educação Física da UNIFACS – Universidade Salvador, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Educação Física.

Orientador: Prof. Dario da Silva Monte Nero

Salvador
2026

Ficha catalográfica

Espaço reservado à ficha catalográfica, que será elaborada pela Biblioteca da UNIFACS após a aprovação do trabalho, conforme o Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2).

ALBERT AELCIO DIAS DA SILVA
HUGO FERREIRA DOS REIS
JOILSON MOURA DOS SANTOS FORTUNA

USO DE ESTEROIDES ANABOLIZANTES POR PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO E O PAPEL DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA: ENTRE A ORIENTAÇÃO E A CONIVÊNCIA

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Educação Física da UNIFACS – Universidade Salvador, pela seguinte banca examinadora:

Data da aprovação: _____ / _____ / _____

_____
Prof. Dario da Silva Monte Nero (Orientador)
UNIFACS – Universidade Salvador

_____
Prof(a). _____ (Membro)
UNIFACS – Universidade Salvador

_____
Prof(a). _____ (Membro)
UNIFACS – Universidade Salvador

Salvador, _____ de _____ de 2026.

Dedicamos este trabalho às nossas famílias, alicerce de tudo o que somos, cujo apoio incondicional e paciência tornaram possível esta caminhada. Dedicamos, ainda, aos profissionais de Educação Física que, diariamente, assumem com seriedade o compromisso ético de cuidar da saúde de quem confia em seu trabalho.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, primeiramente, a Deus e às nossas famílias, pelo amor, pelo incentivo e pela compreensão diante das ausências necessárias à conclusão deste trabalho.

Ao nosso orientador, Prof. Dario da Silva Monte Nero, pela dedicação, pelas valiosas contribuições e pela confiança depositada ao longo de todo o percurso desta pesquisa.

Aos professores do curso de Educação Física da UNIFACS — Universidade Salvador, pelos ensinamentos que formaram a base do nosso conhecimento e da nossa postura profissional.

Aos colegas de curso, pela parceria, pela troca de experiências e pelo apoio nos momentos de dificuldade. A todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho, o nosso sincero agradecimento.

“Não basta ter saúde e sim conhecer a arte de conservá-la, pois a saúde é mais bem preservada pelo conhecimento do que pela ignorância.”

(Francis Bacon, adaptado)

RESUMO

O uso não médico de esteroides anabolizantes androgênicos (EAA) por praticantes de musculação é um fenômeno relevante no Brasil, com prevalências que, em estudos recentes (2020–2025), variaram de 14,48% a 29% entre frequentadores de academias. Associado ao culto ao corpo, à pressão estética e à dismorfia muscular, esse uso coloca o profissional de Educação Física diante de um dilema ético: orientar sobre os riscos ou calar-se diante de uma prática que ocorre em seu próprio ambiente de trabalho. Este estudo teve como objetivo analisar, a partir da literatura científica e dos documentos normativos do Sistema CONFEF/CREFs, o papel e os limites éticos do profissional de Educação Física frente ao uso de EAA por praticantes de musculação. Trata-se de pesquisa básica, qualitativa e descritiva, do tipo revisão integrativa, complementada por análise documental do Código de Ética Profissional (Resolução CONFEF nº 508/2023) e da Lei nº 9.696/1998. O corpus foi composto por 24 documentos (19 estudos científicos, 2 documentos normativos e 3 fontes institucionais e jornalística), analisados por análise de conteúdo temática. Os resultados evidenciaram prevalências expressivas e heterogêneas; sistematizaram os riscos cardiovasculares, hepáticos, endócrinos e psiquiátricos; identificaram deveres éticos gerais de promoção da saúde e de vedação de práticas ilícitas, sem diretriz específica para os EAA; e tipificaram três situações-limite entre orientação e conivência: prescrição velada, omissão e uso próprio pelo profissional. Concluiu-se que a interpretação sistemática dos dispositivos éticos permite reconhecer o dever de atuação proativa, centrada na educação em saúde e no encaminhamento responsável, e que as lacunas formativa e normativa apontam a necessidade de maior discussão do tema na graduação e de protocolos mais claros por parte do Sistema CONFEF/CREFs.

Palavras-chave: Esteroides anabolizantes; Educação Física; Ética profissional; Musculação; Dismorfia muscular.

ABSTRACT

The non-medical use of anabolic-androgenic steroids (AAS) by resistance-training practitioners is a relevant phenomenon in Brazil, with prevalence rates that, in recent studies (2020–2025), ranged from 14.48% to 29% among gym-goers. Associated with body culture, aesthetic pressure, and muscle dysmorphia, this use places the Physical Education professional before an ethical dilemma: to educate about the risks or to remain silent about a practice that occurs within their own work environment. This study aimed to analyze, based on the scientific literature and the normative documents of the CONFEF/CREFs System, the role and ethical limits of the Physical Education professional regarding AAS use by gym-goers. It is a basic, qualitative, descriptive study, using an integrative literature review complemented by document analysis of the Professional Code of Ethics (CONFEF Resolution No. 508/2023) and Law No. 9,696/1998. The corpus comprised 24 documents (19 scientific studies, 2 normative documents, and 3 institutional and journalistic sources), analyzed through thematic content analysis. The results showed expressive but heterogeneous prevalence rates; systematized the cardiovascular, hepatic, endocrine, and psychiatric risks; identified general ethical duties of health promotion and prohibition of unlawful practices, with no specific guidance on AAS; and typified three borderline situations between guidance and complicity: covert prescription, omission, and the professional's own use. It was concluded that a systematic interpretation of the ethical provisions supports the duty of proactive action centered on health education and responsible referral, and that gaps in training and regulation point to the need for greater discussion of the topic in undergraduate education and clearer protocols from the CONFEF/CREFs System.

Keywords: Anabolic steroids; Physical Education; Professional ethics; Resistance training; Muscle dysmorphia.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Espectro de condutas diante do uso de EAA: conivência, orientação responsável e proibicionismo moralista.....45

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Composição do corpus por tipo de documento e por eixo temático (n = 24)..... 39

Gráfico 2 – Distribuição dos estudos científicos por ano de publicação (n = 19)..... 39

Gráfico 3 – Prevalência do uso de EAA entre praticantes de musculação em estudos brasileiros..... 40

Gráfico 4 – Aumento do uso de anabolizantes entre estudantes brasileiros, por nível de ensino..... 41

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Estrutura da estratégia de busca por blocos conceituais.....33
Quadro 2 – Critérios de elegibilidade dos estudos.....34
Quadro 3 – Fluxo de seleção dos estudos da revisão integrativa.....36
Quadro 4 – Matriz-síntese do corpus analisado (n = 24).....37
Quadro 5 – Riscos à saúde associados ao uso não médico de EAA, por sistema....42
Quadro 6 – Deveres ético-profissionais e sua aplicação ao contexto do uso de EAA 43
Quadro 7 – Situações-limite entre orientação e conivência.....44
Quadro 8 – Síntese dos resultados por objetivo específico.....45
Quadro 9 – Roteiro de conduta profissional diante do uso de EAA e sua fundamentação.....49

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Prevalência do uso de EAA segundo os estudos do corpus.....40
Tabela 2 – Estatísticas descritivas das prevalências recentes (n = 4 estudos).....41

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
CNS	Conselho Nacional de Saúde
CONFEF	Conselho Federal de Educação Física
CREF	Conselho Regional de Educação Física
EAA	Esteroides Anabolizantes Androgênicos
LILACS	Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
SBEM	Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
SciELO	Scientific Electronic Library Online
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UNIFACS	Universidade Salvador
USP	Universidade de São Paulo

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....18
1.1 Problema de pesquisa.....18
1.2 Objetivos.....19
1.2.1 Objetivo geral.....19
1.2.2 Objetivos específicos.....19
1.3 Justificativa.....19
2 REVISÃO DE LITERATURA.....21
2.1 Esteroides anabolizantes androgênicos: conceitos e classificação.....21
2.2 Prevalência do uso de EAA no Brasil.....23
2.3 Fatores motivacionais: estética, pressão social e dismorfia muscular.....25
2.4 Riscos à saúde associados ao uso não médico de EAA.....27
2.5 O Código de Ética Profissional e as responsabilidades do educador físico.....29
2.6 Dilemas éticos: entre orientar e ser conivente.....31
3 METODOLOGIA.....33
3.1 Tipo de pesquisa.....33
3.2 Estratégia de busca.....33
3.3 Critérios de inclusão e exclusão.....34
3.4 Análise documental.....34
3.5 Análise dos dados.....34
4 RESULTADOS.....36
4.1 Caracterização do corpus analisado.....36
4.2 Prevalência e fatores motivacionais do uso de EAA.....39
4.3 Riscos à saúde associados ao uso não médico de EAA.....42
4.4 Responsabilidades e deveres ético-profissionais do educador físico.....43
4.5 Limites entre orientação e conivência.....44
4.6 Síntese dos resultados.....45
5 DISCUSSÃO.....46
5.1 A magnitude do fenômeno e seus determinantes.....46
5.2 Os riscos à saúde como fundamento do dever de cuidado.....47
5.3 A lacuna normativa e a insuficiência da formação.....47
5.4 Entre orientar e ser conivente: o tensionamento do dilema ético.....48
5.5 Proposição de conduta profissional (proposta dos autores).....48
6 CONCLUSÃO.....50
REFERÊNCIAS.....52
APÊNDICE A – MODELO DE ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO ANÔNIMO.....55

APÊNDICE B – MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE).....57
ANEXO A – RESOLUÇÃO CONFEF Nº 508/2023.....59

1 INTRODUÇÃO

O culto ao corpo e a busca pelo padrão estético vigente têm impulsionado, nas últimas décadas, o uso de esteroides anabolizantes androgênicos (EAA) por praticantes de musculação em academias brasileiras. Estudos realizados em diferentes populações de praticantes identificaram prevalências expressivas, embora os valores variem de acordo com o perfil amostral e os procedimentos metodológicos empregados: Morato et al. (2020) encontraram cerca de 29% de uso entre praticantes de musculação, enquanto Júnior et al. (2024) e Carmo et al. (2025) registraram índices que permanecem relevantes, especialmente entre homens jovens. A Vigilância Sanitária alerta que o uso não médico de EAA configura problema de saúde pública (BRASIL, 2024).

Nesse cenário, o profissional de Educação Física ocupa posição privilegiada e, ao mesmo tempo, desconfortável: é quem acompanha de perto a rotina de treino do aluno, convive diariamente com o ambiente de academia e pode estar entre os primeiros profissionais a observar sinais associados ao uso de EAA. No entanto, a análise do Código de Ética Profissional (Resolução CONFEF nº 508/2023) evidencia a ausência de orientação operacional específica acerca da conduta do profissional diante da identificação ou suspeita de uso não médico de EAA, limitando-se o documento a estabelecer deveres gerais de promoção da saúde e de vedação de práticas ilícitas.

Diante desse quadro, o presente trabalho busca compreender como a literatura científica e os documentos normativos do Sistema CONFEF/CREFs delimitam o papel do profissional de Educação Física quando o uso de EAA se faz presente no ambiente em que atua. Parte-se do pressuposto de que o dilema entre orientar e ser conivente não se resolve nem pela permissividade nem pelo proibicionismo moralista, mas por uma atuação fundamentada em evidências, respeitosa dos limites legais da profissão e comprometida com o cuidado do praticante.

1.1 Problema de pesquisa

De que forma a literatura científica e os dispositivos normativos do Sistema CONFEF/CREFs definem o papel e os limites éticos do profissional de Educação Física diante do uso de anabolizantes por praticantes de musculação em academias?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Analisar, a partir da revisão da literatura científica e dos documentos normativos do Sistema CONFEF/CREFs, o papel e os limites éticos do profissional de Educação Física frente ao uso de esteroides anabolizantes por praticantes de musculação.

1.2.2 Objetivos específicos

Constituem objetivos específicos deste estudo:

a) Identificar a prevalência do uso de EAA por praticantes de musculação no contexto brasileiro e os principais fatores motivacionais (estética, pressão social, dismorfia muscular);

b) Descrever os riscos à saúde associados ao uso não médico de EAA, com base na produção científica recente;

c) Analisar as responsabilidades e os deveres éticos do profissional de Educação Física conforme o Código de Ética Profissional (Resolução CONFEF nº 508/2023);

d) Discutir os limites entre orientação e conivência, identificando situações-limite relatadas na literatura (prescrição velada, omissão diante do uso, uso próprio pelo profissional).

1.3 Justificativa

A escolha do tema justifica-se em três dimensões: a relevância social, a relevância acadêmica e a relevância profissional e formativa.

Do ponto de vista social, o uso não médico de EAA atinge números preocupantes, sobretudo entre os mais jovens. Levantamento divulgado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e noticiado pelo Jornal da USP (2024) aponta aumentos expressivos do consumo entre estudantes da educação básica ao longo das últimas décadas. Esses percentuais provêm de material de divulgação institucional e jornalística e, por isso, são tratados neste trabalho como indicativos, e não como estimativas epidemiológicas definitivas. A literatura científica e os documentos de saúde pública, por sua vez, associam o uso não médico de EAA a disfunções cardiovasculares, hepáticas, endócrinas e psiquiátricas (BRASIL, 2024).

Do ponto de vista acadêmico, observa-se escassez de trabalhos que articulem diretamente o uso de EAA à normatização ético-profissional da Educação Física: a produção nacional concentra-se na prevalência e nos efeitos adversos, e menos na

conduta esperada do profissional. Este estudo busca contribuir para o preenchimento dessa lacuna, ao confrontar as evidências científicas com os dispositivos do Código de Ética Profissional.

Do ponto de vista profissional e formativo, a literatura aponta lacunas no conhecimento sobre EAA entre estudantes e profissionais da área (BASTOS et al., 2019; MACHADO et al., 2020). Discutir o tema contribui, assim, para a formação de profissionais mais preparados para orientar com segurança, sem prescrever e sem se omitir.

Além desta introdução, o trabalho estrutura-se em mais cinco seções. A seção 2 apresenta a revisão de literatura; a seção 3 descreve a metodologia; a seção 4 expõe os resultados; a seção 5 discute os achados e propõe um roteiro de conduta profissional; e a seção 6 apresenta as conclusões, as limitações e as sugestões para pesquisas futuras.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Esteroides anabolizantes androgênicos: conceitos e classificação

Os esteroides anabolizantes androgênicos (EAA) são derivados sintéticos da testosterona, hormônio sexual masculino produzido naturalmente pelos testículos, ovários e córtex adrenal. A nomenclatura “anabolizante androgênico” reflete a dupla ação dessas substâncias: o efeito anabólico, responsável pelo aumento da síntese proteica e, consequentemente, pela hipertrofia muscular; e o efeito androgênico, que promove o desenvolvimento e a manutenção das características sexuais masculinas (HARTGENS; KUIPERS, 2004; KICMAN, 2008).

Do ponto de vista histórico, a origem dos EAA remonta a experimentos que antecedem a própria síntese da testosterona. Em 1849, o fisiologista alemão Arnold Adolph Berthold demonstrou, em experimentos com galos castrados, que a retirada dos testículos impedia o desenvolvimento das características masculinas, enquanto o reimplante das gônadas restaurava tais atributos — mesmo sem conexão nervosa —, sugerindo a ação de um fator transportado pelo sangue, posteriormente identificado como testosterona (KICMAN, 2008; KANAYAMA; POPE JR., 2018). O termo “hormônio”, por sua vez, foi cunhado em 1905 pelo fisiologista britânico Ernest Starling, em conferência no Royal College of Physicians, definindo-o como mensageiro químico responsável por influenciar funções corporais (STARLING, 1905).

O marco fundamental na história dos EAA ocorreu em 1935, quando o químico holandês Ernst Laqueur isolou a testosterona a partir de extratos testiculares, e, no mesmo ano, os químicos Adolf Butenandt e Leopold Ruzicka sintetizaram a molécula independentemente a partir de derivados do colesterol, conquista que lhes valeu o Prêmio Nobel de Química de 1939 (ALMEIDA, 2010; KANAYAMA; POPE JR., 2018). Logo após a síntese, Kochakian e Murlin (1936) demonstraram que a administração de testosterona promovia retenção de nitrogênio — indicador direto da síntese proteica —, evidenciando pela primeira vez o potencial anabólico da substância. Essa descoberta inaugurou uma nova fase de interesse científico e farmacológico no desenvolvimento de compostos que retivessem os efeitos anabólicos da testosterona, minimizando os efeitos androgênicos indesejados.

Foi nesse contexto que o médico John Ziegler, da equipe olímpica norte-americana, experimentou a administração de testosterona a atletas nos anos 1950 e, em seguida, colaborou com o laboratório CIBA no desenvolvimento da metandrostenolona — comercializada como Dianabol —, lançada em 1958 (KICMAN, 2008). O fármaco prometia ganhos rápidos de massa e força muscular e rapidamente se difundiu entre fisiculturistas e atletas de modalidades de força. A década de 1960

assistiu à proliferação de novos compostos, como o estanozolol (Winstrol, 1962), a oxandrolona (Anavar, 1964) e o decanoato de nandrolona (Deca-Durabolin, anos 1960), cada qual com perfil farmacocinético distinto, oferecendo aos usuários maior variedade de escolha conforme os objetivos estéticos ou de performance almejados (HARTGENS; KUIPERS, 2004).

No Brasil, o percurso dos EAA segue tendência semelhante. Almeida (2010) registra que os anabolizantes chegaram ao país na esteira da expansão do fisiculturismo e da cultura de academia, inicialmente no eixo Rio–São Paulo, nos anos 1970 e 1980, e posteriormente se disseminaram para capitais e interior. A comercialização irregular, aliada à facilidade de aquisição em farmácias sem prescrição médica — problema que persiste até hoje, conforme dados da Vigilância Sanitária —, contribuiu para que o uso não médico se tornasse endêmico no ambiente das academias brasileiras (ABRAHIN; SOUZA; FERREIRA, 2013).

Do ponto de vista farmacológico, os EAA podem ser classificados conforme a via de administração (oral ou injetável), a estrutura química (derivados 17-alquilados ou ésteres de testosterona) e a relação anabólica/androgênica. Os compostos orais, como a metandrostenolona e a oxandrolona, sofrem modificação na posição 17-alpha do anel esteroide para resistir ao metabolismo hepático de primeira passagem, o que, embora viabilize a administração por via oral, confere-lhes hepatotoxicidade significativa (KICMAN, 2008). Os compostos injetáveis, como o decanoato de nandrolona e o cipionato de testosterona, são ésteres de liberação lenta, administrados por via intramuscular, com menor impacto hepático direto, mas não isentos de riscos cardiovasculares, endócrinos e psiquiátricos (HARTGENS; KUIPERS, 2004). A chamada relação anabólica/androgênica, expressa em valores derivados de testes pré-clínicos, indica a proporção relativa de cada efeito; contudo, tal classificação é frequentemente mal interpretada por usuários leigos, que acreditam ser possível separar completamente os efeitos anabólicos dos androgênicos — o que a farmacologia não sustenta (KICMAN, 2008).

É fundamental distinguir o uso terapêutico do uso não médico. O emprego clínico dos EAA permanece legítimo e indicado em condições como hipogonadismo masculino, anemias aplásticas, caquexia associada ao HIV/câncer, osteoporose severa e queimaduras extensas, sempre sob prescrição e acompanhamento médicos (KICMAN, 2008; HARTGENS; KUIPERS, 2004). O uso não médico, por sua vez, caracteriza-se pela autoadministração de dosagens suprafisiológicas — frequentemente superiores às utilizadas em contextos terapêuticos e habitualmente administradas sem acompanhamento clínico adequado —, em ciclos combinados (“*stacks*”) e com períodos de descanso entre ciclos, prática sem respaldo científico e

associada a uma ampla gama de efeitos adversos (WU, 1997; ABRAHIN; SOUZA; FERREIRA, 2013).

Assim, os EAA constituem um grupo farmacológico cuja história percorre da ciência básica ao doping esportivo, do uso clínico ao abuso estético, e cuja compreensão é requisito indispensável para que o profissional de Educação Física possa atuar com competência e responsabilidade ética junto a praticantes de musculação que, potencialmente, fazem uso dessas substâncias.

2.2 Prevalência do uso de EAA no Brasil

A mensuração da prevalência do uso de esteroides anabolizantes androgênicos (EAA) no Brasil constitui um desafio metodológico particular, uma vez que se trata de um comportamento socialmente estigmatizado, frequentemente clandestino e associado a práticas ilegais de aquisição e administração. Em razão disso, os dados disponíveis na literatura nacional apresentam ampla variação, dependendo do desenho do estudo, do perfil da amostra, da região geográfica investigada e dos instrumentos utilizados para a coleta de informações. Ainda assim, o conjunto de evidências acumulado ao longo das últimas décadas permite afirmar que o consumo dessas substâncias entre praticantes de musculação no país é expressivo, ainda que os valores variem consideravelmente entre os estudos.

Um dos estudos de referência sobre o tema é a revisão conduzida por Abrahin, Souza e Ferreira (2013), que sistematizou a produção científica brasileira acerca do uso de EAA. Segundo os autores, a prevalência do consumo dessas substâncias variou de forma considerável entre 2,1% e 25,5%, conforme as características da amostra e a região analisada. Essa amplitude reflete tanto a heterogeneidade dos contextos investigados quanto as dificuldades inerentes à obtenção de dados fidedignos sobre um comportamento que muitos usuários preferem ocultar. Ainda assim, mesmo os menores percentuais registrados revelam a existência de um contingente relevante de indivíduos expostos aos riscos associados ao uso não terapêutico dessas drogas.

Investigações realizadas especificamente em ambientes de academia corroboram a magnitude do fenômeno. Nogueira e colaboradores (2013), em revisão sistemática sobre o uso de recursos ergogênicos por praticantes de musculação nas academias brasileiras, concluíram que tanto o consumo de suplementos alimentares quanto o de esteroides anabólicos androgênicos encontram-se exacerbados nesses espaços, especialmente em determinadas regiões do país. Os autores destacam que a academia, longe de ser um ambiente neutro, configura-se muitas vezes como um espaço de socialização em torno de práticas de dopagem estética, no qual o acesso às

substâncias e as informações sobre seu uso circulam de maneira informal entre os frequentadores.

Estudos posteriores confirmaram e detalharam esse panorama. Oliveira e colaboradores (2018) identificaram, em pesquisa sobre a frequência do uso de EAA e o perfil de seus usuários, que a busca por hipertrofia e por melhora da aparência física figura entre as principais motivações relatadas, com predomínio expressivo do sexo masculino. Morato e colaboradores (2020), por sua vez, encontraram prevalência de uso de anabolizantes de 29% entre praticantes de musculação avaliados, cifra ainda mais elevada quando analisado isoladamente o público masculino. Esse resultado situa-se no limite superior das estimativas apontadas por Abrahin, Souza e Ferreira (2013) e reforça a percepção de que, em determinados contextos, o consumo dessas substâncias deixa de ser exceção para tornar-se prática relativamente disseminada.

Dados mais recentes mantêm a tendência de patamares preocupantes. Monteiro et al. (2023), em estudo com praticantes de musculação de três academias, observaram que 20,20% dos entrevistados já haviam feito ou faziam uso de esteroides anabolizantes. Júnior e colaboradores (2024) registraram prevalência de 14,48%, com predomínio de usuários do sexo masculino, autodeclarados de cor branca e tendo a hipertrofia muscular como principal objetivo. Já Carmo e colaboradores (2025), em amostra de 257 participantes, verificaram que 16,73% relataram o uso de EAA, com predominância na faixa etária entre 31 e 50 anos. Esses achados, obtidos em diferentes momentos, localidades e com metodologias distintas, não devem ser comparados diretamente entre si, mas, em conjunto, indicam percentuais que, embora minoritários, representam parcela significativa da população que frequenta academias no Brasil.

No plano internacional, a meta-análise de Sagoe et al. (2014) estimou prevalência global do uso de EAA ao longo da vida de 3,3% na população geral, com 6,4% entre homens e 1,6% entre mulheres. Embora a comparação direta com estudos realizados em academias exija cautela, por se tratarem de populações distintas, o contraste com os percentuais observados entre praticantes de musculação no Brasil sugere que o ambiente de academia concentra o consumo em magnitude superior à da população geral.

Um aspecto especialmente inquietante diz respeito ao avanço do consumo entre os mais jovens. Levantamento divulgado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, noticiado pela Universidade de São Paulo (Jornal da USP, 2024), aponta que um em cada dezesseis estudantes brasileiros já utilizou anabolizantes. Ainda segundo esses dados, entre 1996 e os anos recentes houve aumento de 39% no uso dessas substâncias entre estudantes do ensino fundamental, de 67% entre os do ensino médio e de 84% entre os concluintes da educação básica.

Tais números indicam que a exposição aos EAA tem início cada vez mais precoce, o que amplia a janela temporal de vulnerabilidade a efeitos adversos e consolida hábitos de risco em fases decisivas do desenvolvimento físico e psicológico.

O conjunto dessas evidências permite delinear um cenário nacional em que o uso de EAA por praticantes de musculação constitui questão de saúde pública, e não apenas comportamento individual isolado. A recorrência de prevalências situadas entre 14% e 29% em estudos com metodologias distintas, somada ao crescimento documentado entre adolescentes, evidencia a dimensão do problema e justifica a atenção específica dos profissionais de Educação Física. É precisamente nesse contexto de disseminação que emerge a relevância de compreender os fatores que motivam o consumo, os riscos à saúde envolvidos e o papel ético do educador físico diante de uma prática cada vez mais presente em seu cotidiano de trabalho — temas que serão abordados nas seções subsequentes.

2.3 Fatores motivacionais: estética, pressão social e dismorfia muscular

O fenômeno do culto ao corpo constitui pano de fundo indispensável para essa análise. Em estudo já clássico sobre o tema, Iriart e colaboradores (2009) investigaram as motivações para a prática da musculação e o uso de anabolizantes, evidenciando como o corpo se converteu, nas sociedades contemporâneas, em objeto privilegiado de investimento identitário e de reconhecimento social. Nesse cenário, a aparência física passa a funcionar como capital simbólico, associada a valores como disciplina, sucesso e autocontrole. O corpo musculoso deixa de ser mero atributo estético para tornar-se marca de distinção social, o que ajuda a explicar a disposição de muitos indivíduos em assumir riscos consideráveis à saúde em nome de um ideal corporal.

A pressão social em torno desse ideal foi intensificada, nas últimas décadas, pela expansão das mídias digitais. A exposição contínua a imagens de corpos idealizados nas redes sociais, muitas vezes editadas ou obtidas mediante uso de substâncias não declaradas, cria parâmetros de comparação inatingíveis por meios naturais. Influenciadores fitness, atletas e figuras públicas promovem, direta ou indiretamente, uma estética hipermuscular que passa a ser percebida como norma desejável. Esse ambiente digital funciona como poderoso vetor de normalização do uso de EAA, ao apresentar resultados extraordinários como fruto exclusivo de treino e disciplina, ocultando o recurso a substâncias e minimizando seus riscos (MOUZINHO et al., 2025).

No plano clínico, a manifestação mais expressiva dessa dinâmica é a dismorfia muscular, também denominada vigorexia. Trata-se de um transtorno da imagem corporal, classificado no espectro obsessiva-compulsivo, no qual o indivíduo se percebe insuficientemente musculoso mesmo quando apresenta desenvolvimento

físico normal ou acentuado. Camargo e colaboradores (2008) caracterizam a vigorexia como uma variação do transtorno dismórfico corporal, marcada por preocupação obsessiva com a musculatura, dedicação excessiva ao treino e adesão a dietas rígidas, frequentemente acompanhadas do uso de suplementos e anabolizantes. O portador tende a organizar sua rotina em torno da academia, sacrificando relações sociais e profissionais, e a experimentar sofrimento intenso diante da percepção distorcida do próprio corpo.

A relação entre dismorfia muscular e uso de EAA é amplamente documentada. Amorim e colaboradores (2025), em investigação sobre a associação entre esses fenômenos, apontam que praticantes com sintomas de dismorfia muscular apresentam maior propensão ao consumo dessas substâncias, num ciclo de reforço mútuo: a insatisfação corporal impulsiona o uso, e os resultados obtidos alimentam a busca por ganhos cada vez maiores, jamais suficientes aos olhos do usuário. Diniz (2021), em revisão sobre a relação entre o transtorno de vigorexia e o uso de anabolizantes, reforça essa leitura ao demonstrar que a distorção da autoimagem constitui fator de risco relevante para o consumo não terapêutico dessas drogas.

Estudos mais recentes ampliam essa compreensão ao situar o fenômeno no contexto digital contemporâneo. Mouzinho e colaboradores (2025), em revisão narrativa sobre as relações entre vigorexia e uso de esteroides anabolizantes, identificam a intensificação do transtorno em decorrência da pressão estética veiculada pelas redes sociais, apontando a vigorexia como quadro clínico crescente entre jovens. De modo convergente, Soler e colaboradores (2013), ao analisarem a relação entre vigorexia e níveis de dependência de exercício em frequentadores de academia, evidenciam que o comportamento compulsivo em relação ao treino frequentemente se associa a práticas de risco, entre as quais o uso de anabolizantes.

O conjunto dessas evidências revela que os fatores motivacionais do uso de EAA formam uma trama complexa, na qual se entrelaçam a valorização cultural do corpo musculoso, a pressão social amplificada pelas mídias digitais, a estigmatização de corpos dissonantes do padrão vigente e a presença de transtornos psicológicos como a dismorfia muscular. Reconhecer essa multiplicidade de determinantes é fundamental para o profissional de Educação Física, uma vez que a decisão de usar anabolizantes raramente se explica por escolha puramente racional e informada, estando antes ancorada em vulnerabilidades subjetivas e pressões sociais que demandam acolhimento, orientação qualificada e, quando necessário, encaminhamento a outros profissionais de saúde — dimensões éticas que serão aprofundadas adiante.

2.4 Riscos à saúde associados ao uso não médico de EAA

O uso não médico de esteroides anabolizantes androgênicos (EAA) está associado a um amplo espectro de efeitos adversos, que atingem praticamente todos os sistemas do organismo. A gravidade e a reversibilidade desses efeitos variam conforme o tipo de substância utilizada, a dose administrada, o tempo de exposição, a via de administração e as características individuais do usuário. Um agravante recorrente no contexto da musculação recreativa é o fato de que as doses empregadas com finalidade estética costumam ser consideravelmente superiores às utilizadas para fins terapêuticos, o que amplia o potencial de dano. Como ressaltam Hartgens e Kuipers (2004), os riscos decorrem não apenas das propriedades farmacológicas das drogas, mas também dos padrões de uso não supervisionado característicos do consumo estético.

Entre os efeitos mais preocupantes estão os de natureza cardiovascular. Liu e Wu (2019), em revisão sobre o risco cardiovascular associado aos EAA, demonstram que essas substâncias produzem efeitos tóxicos sobre o sistema circulatório, contribuindo para alterações no perfil lipídico, hipertrofia do ventrículo esquerdo, hipertensão arterial, arritmias e maior propensão à formação de placas ateroscleróticas. Tais alterações elevam o risco de eventos graves, como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, inclusive em indivíduos jovens e aparentemente saudáveis. A cardiotoxicidade dos EAA é particularmente insidiosa por evoluir muitas vezes de forma silenciosa, manifestando-se de maneira aguda apenas em estágios avançados.

O fígado constitui outro órgão especialmente vulnerável, sobretudo em relação aos anabolizantes de administração oral, cuja estrutura química — os compostos 17-alfa-alquilados — confere resistência à degradação hepática, mas ao custo de elevada hepatotoxicidade. Solimini e colaboradores (2017), em revisão sobre os efeitos hepatotóxicos do uso ilícito dessas substâncias, relatam a ocorrência de elevação de enzimas hepáticas, colestase, lesões como a peliose hepática — caracterizada pela formação de cavidades preenchidas por sangue no parênquima — e, em casos extremos, tumores hepáticos. Esses achados reforçam a periculosidade do uso oral prolongado, frequentemente subestimada pelos usuários.

Manifestações dermatológicas figuram entre os efeitos mais visíveis e frequentes. O estímulo androgênico das glândulas sebáceas favorece o surgimento de acne severa, pele oleosa e, em predispostos, aceleração da calvície de padrão masculino. Embora menos graves do que as complicações cardiovasculares e hepáticas, esses sinais possuem valor clínico relevante, pois funcionam como indicadores externos de uso que o profissional atento pode identificar no cotidiano da academia, abrindo espaço para o diálogo e a orientação (KICMAN, 2008).

No plano psiquiátrico e comportamental, os EAA associam-se a alterações de humor, irritabilidade, agressividade acentuada — popularmente designada por expressões que remetem a surtos de fúria —, episódios de mania, quadros depressivos e sintomas paranoides. Kanayama, Hudson e Pope Jr. (2008), em revisão sobre as consequências psiquiátricas e médicas de longo prazo do abuso dessas substâncias, alertam para o risco de dependência, especialmente relevante quando se considera que a interrupção do uso pode desencadear sintomas de abstinência, incluindo depressão grave com ideação suicida. Esse componente adictivo aproxima o consumo de EAA de outros transtornos por uso de substâncias, complexificando o quadro clínico e o manejo.

Uma preocupação adicional recai sobre os usuários adolescentes, cujo organismo ainda se encontra em desenvolvimento. A exposição precoce aos EAA pode provocar o fechamento prematuro das placas epifisárias dos ossos longos, comprometendo o crescimento e resultando em estatura final reduzida. Somam-se a isso os riscos já mencionados, potencializados pela imaturidade dos sistemas orgânicos e pela maior vulnerabilidade psicológica própria dessa faixa etária, o que torna o uso nesse grupo especialmente alarmante — sobretudo diante do crescimento do consumo entre jovens documentado na literatura recente (VAN AMSTERDAM; OPPERHUIZEN; HARTGENS, 2010).

Um fator que agrava todo esse panorama é o caráter clandestino do uso não médico. Van Amsterdam, Opperhuizen e Hartgens (2010) chamam a atenção para o fato de que boa parte das substâncias consumidas com finalidade estética é obtida no mercado ilegal, sem controle de qualidade, o que expõe os usuários a produtos falsificados, contaminados ou de composição desconhecida. A prática frequente de associar diferentes anabolizantes — o chamado empilhamento, ou *stacking* — e de recorrer a doses supraterapêuticas, sem qualquer acompanhamento médico, multiplica os riscos e dificulta a identificação precoce de complicações. A automedicação, baseada em informações obtidas de fontes não qualificadas, é regra, e não exceção, nesse universo.

No plano internacional, a declaração científica da Endocrine Society (POPE JR. et al., 2014) sistematizou as consequências adversas à saúde associadas ao uso de substâncias para a melhora de desempenho, entre elas os esteroides anabolizantes, em convergência com os achados da literatura nacional e com a necessidade de abordagem preventiva.

Diante desse conjunto de evidências, torna-se evidente que o uso não médico de EAA configura problema de saúde de gravidade considerável, com potencial para causar danos permanentes e, em casos extremos, morte prematura. Abrahin, Souza e Ferreira (2013), ao sistematizarem os efeitos colaterais dessas substâncias, reforçam

que os riscos superam largamente os eventuais benefícios estéticos buscados pelos usuários. Esse reconhecimento tem implicações diretas para a atuação do profissional de Educação Física, que, na condição de agente de saúde e figura de referência no ambiente da academia, ocupa posição privilegiada para identificar sinais de uso, prestar orientação baseada em evidências e promover encaminhamentos adequados — responsabilidades éticas que serão discutidas nas seções seguintes.

2.5 O Código de Ética Profissional e as responsabilidades do educador físico

O exercício profissional da Educação Física no Brasil é regulamentado pela Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1998 (BRASIL, 1998), que instituiu o Sistema CONFEF/CREFs — composto pelo Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) e pelos Conselhos Regionais (CREFs) —, responsável por normatizar e fiscalizar a atuação dos profissionais da área. Nesse arcabouço, o Código de Ética Profissional, disciplinado atualmente pela Resolução CONFEF nº 508/2023 (CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 2023), que revogou a Resolução nº 307/2015 (CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 2015), estabelece os princípios, deveres e vedações que orientam a conduta do educador físico. É à luz desse documento que se deve compreender o papel do profissional diante do uso de esteroides anabolizantes androgênicos (EAA) por seus beneficiários.

O primeiro aspecto a destacar é a concepção do profissional de Educação Física como agente de promoção da saúde. O Código de Ética estabelece, entre as responsabilidades e deveres da categoria, promover a Educação Física como meio efetivo para a conquista de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável, voltado à promoção e preservação da saúde dos beneficiários. Essa diretriz posiciona a saúde — e não o desempenho estético a qualquer custo — como valor central da intervenção profissional, o que entra em tensão direta com a lógica do uso de anabolizantes, orientada por resultados rápidos e frequentemente incompatíveis com a integridade física do usuário.

O Código de Ética contém ainda deveres que se aplicam de modo específico ao contexto ora analisado. Cabe ao profissional assegurar aos beneficiários um serviço seguro, competente e atualizado, prestado com excelência técnica; elaborar o programa de atividades em função das condições gerais de saúde de cada indivíduo; e mantê-lo informado sobre eventuais circunstâncias adversas que possam influenciar o trabalho prestado. Soma-se a esses o dever de manter-se atualizado sobre a produção científica, requisito indispensável para que a orientação oferecida se baseie em evidências, e não em senso comum ou em práticas difundidas informalmente no ambiente da academia. Esses dispositivos, em conjunto, impõem ao educador físico o

dever de informar o beneficiário sobre os riscos do uso de EAA de maneira técnica e fundamentada.

Se, por um lado, o Código prescreve deveres positivos, por outro estabelece vedações expressas que delimitam o campo do ilícito ético. É vedado ao profissional praticar, permitir ou estimular, no exercício da profissão, ato que a lei defina como crime ou contravenção, bem como vincular seu nome ou registro profissional a atividades ilícitas. É igualmente vedado divulgar ou publicar, nas redes sociais ou em qualquer plataforma digital, conteúdos tecnicamente infundados ou inapropriados que possam causar danos aos beneficiários e à profissão. Tais vedações têm aplicação imediata ao tema dos anabolizantes: recomendar, prescrever, indicar fornecedores ou de qualquer forma promover o uso dessas substâncias configura infração ética grave, sujeita a processo disciplinar.

Deve-se observar, contudo, que o dever ético do profissional não se limita à abstenção de condutas proibidas. O compromisso com a promoção da saúde e com a prestação de orientação segura implica um dever positivo de ação diante da constatação do uso de EAA. Isso inclui informar o beneficiário sobre os riscos de forma acessível e fundamentada, acolher suas motivações sem julgamento moralizante e, quando necessário, encaminhá-lo a outros profissionais de saúde — médicos, nutricionistas e psicólogos — aptos a oferecer o cuidado que escapa à competência do educador físico. A atuação ética, nesse sentido, exige postura ativa e articulada com a rede de cuidado em saúde.

Cumpre destacar, por fim, que o próprio Sistema CONFEF/CREFs tem assumido posição institucional explícita contra o uso não médico de anabolizantes, reconhecendo-o como problema de saúde pública. Campanhas como a promovida pelo CREF3/SC (2026), que articula profissionais de diferentes áreas para alertar a população sobre os riscos e para combater a pressão estética veiculada nas redes sociais, evidenciam que a questão transcende a conduta individual e integra a agenda coletiva da categoria. Tais iniciativas reforçam o entendimento de que o profissional de Educação Física é corresponsável pela proteção da saúde de seus beneficiários e da sociedade.

Em síntese, o Código de Ética Profissional oferece parâmetros claros para a atuação do educador físico diante do uso de EAA: promover a saúde, prestar orientação técnica e segura, informar sobre riscos, manter-se atualizado e abster-se de qualquer conduta que estimule ou legitime o uso dessas substâncias. Ocorre que, entre a norma e a prática cotidiana, interpõem-se situações de considerável complexidade, nas quais o profissional se vê diante de dilemas concretos que os dispositivos éticos, isoladamente, não resolvem. É justamente essa zona de tensão —

entre o dever de orientar e o risco de ser conivente — que será objeto de análise na seção seguinte.

2.6 Dilemas éticos: entre orientar e ser conivente

A discussão desenvolvida até aqui evidencia uma assimetria incômoda: enquanto o arcabouço normativo que rege a profissão é inequívoco ao vedar a prescrição de substâncias e ao impor o dever de zelar pela saúde do assistido, a realidade cotidiana das academias é marcada por zonas cinzentas que o texto legal, isoladamente, não resolve. É nesse intervalo entre a norma e a prática que se instala o dilema ético central deste trabalho: até que ponto vai a orientação técnica legítima e a partir de que momento o profissional de Educação Física passa a ser conivente com o uso não médico de esteroides anabolizantes? A resposta não é trivial, pois as fronteiras entre informar, tolerar, omitir e induzir são, na experiência concreta, tenuíssimas e frequentemente atravessadas por pressões econômicas, culturais e afetivas.

Um primeiro aspecto a considerar é que o dilema não é externo à categoria profissional, mas a atravessa desde a sua formação. Machado et al. (2020), ao investigarem estudantes-fisiculturistas de cursos de graduação em Educação Física, identificaram um paradoxo revelador: os futuros profissionais aprendem sobre ciclos, dosagens e manejo de efeitos colaterais dos EAA por conta própria, em circuitos informais de troca de experiências, e não no ambiente acadêmico formal, que tende a silenciar sobre o tema. Esse déficit formativo é corroborado por Bastos et al. (2019), que apontaram lacunas expressivas no conhecimento técnico-científico de profissionais em formação a respeito dos esteroides, e por Mattos et al. (2019), que documentaram a própria prevalência de uso entre estudantes de Educação Física. Forma-se, assim, um círculo problemático: o profissional que não foi devidamente preparado para orientar tende, por insuficiência técnica ou por proximidade com a cultura do uso, a reproduzir práticas de convivência acrítica com os anabolizantes.

É preciso reconhecer que muitas dessas condutas não decorrem de má-fé, mas de um contexto estrutural que pressiona o profissional. O mercado do fitness opera sob a lógica da fidelização e do resultado rápido, e o educador físico que insiste em advertir sobre riscos ou em recusar a colaboração com o uso pode ser percebido como um obstáculo aos objetivos do cliente, com prejuízo direto à sua remuneração. Some-se a isso a naturalização do uso promovida por redes sociais e por influenciadores, discutida nas seções anteriores, e a informalidade do mercado de substâncias, e ter-se-á um cenário em que a conivência passiva se apresenta como o caminho de menor resistência. Compreender essa dimensão estrutural não exime o profissional de

responsabilidade, mas desloca a análise de uma perspectiva meramente moralista para uma leitura mais atenta às condições reais do exercício profissional.

No centro do dilema encontra-se a tensão entre duas racionalidades éticas aparentemente inconciliáveis. De um lado, a perspectiva proibicionista, que, ancorada na ilegalidade e nos riscos à saúde, prescreve a recusa absoluta de qualquer diálogo que pareça tolerar o uso. De outro, a perspectiva da redução de danos, que parte do reconhecimento pragmático de que o usuário, muitas vezes, não abandonará a prática pela simples advertência moral e de que privá-lo de informação qualificada pode agravá-la. Ferreira, Palma e Pasquim (2023), ao analisarem os processos críticos de redução de danos entre praticantes de musculação que consomem esteroides, evidenciam que a abordagem moralizante e punitiva tende a afastar o usuário dos serviços de saúde, empurrando-o para a clandestinidade e para fontes de informação ainda menos confiáveis. O paradoxo é agudo: o profissional que, em nome do rigor ético, simplesmente condena e abandona o aluno pode, na prática, produzir mais dano do que aquele que, sem prescrever, mantém o canal de diálogo aberto.

Desse modo, o dilema ético entre orientar e ser conivente só se resolve quando se abandona a leitura maniqueísta que opõe permissividade e proibicionismo. A conivência, seja na forma da prescrição velada, seja na forma da omissão silenciosa, constitui violação ética porque abdica do dever de cuidado em favor da conveniência; mas o proibicionismo moralista, ao abandonar o usuário, também falha, ainda que por outra via, com esse mesmo dever. Entre os dois, delineia-se um terceiro caminho — o da orientação responsável, fundamentada em evidências, respeitosa dos limites legais da profissão e comprometida com a integralidade da saúde do praticante. É justamente a viabilidade e os contornos desse caminho intermediário que a análise dos dados coletados nesta pesquisa buscará iluminar, confrontando o que preconiza a literatura científica e o arcabouço normativo com as práticas efetivamente descritas no campo da musculação.

3 METODOLOGIA

3.1 Tipo de pesquisa

A presente pesquisa classifica-se, quanto à natureza, como básica, pois visa gerar conhecimento sem aplicação imediata. Quanto à abordagem, é qualitativa, uma vez que os dados analisados são textuais e interpretativos. Quanto ao objetivo, é descritiva, pois busca caracterizar o fenômeno e suas relações. Quanto aos procedimentos, trata-se de uma revisão integrativa da literatura, método que permite reunir e sintetizar estudos de diferentes delineamentos sobre um mesmo tema (WHITTEMORE; KNAFL, 2005; SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010), complementada por análise documental.

Ressalta-se que este estudo se restringe à revisão integrativa e à análise documental, não contemplando coleta de dados primários. O questionário (Apêndice A) e o respectivo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B) são apresentados como instrumentos propostos para eventual aplicação futura em pesquisa de campo, condicionada à prévia submissão e aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).

3.2 Estratégia de busca

A busca foi realizada nas bases de dados SciELO (*Scientific Electronic Library Online*), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), PubMed e Google Acadêmico, ao longo do ano de 2026, com filtro de período (2011 a 2026) e de idioma (português e inglês). Os descritores foram organizados em três blocos conceituais, combinados entre si pelo operador booleano AND e, dentro de cada bloco, pelo operador OR, conforme o Quadro 1. A busca nas bases foi complementada pela consulta às listas de referências dos estudos recuperados.

Quadro 1 – Estrutura da estratégia de busca por blocos conceituais

Bloco	Descritores (combinados por OR)	Operador entre blocos
1 – Substâncias	“esteroides anabolizantes”; “anabolizantes”; “doping”	AND
2 – Contexto	“musculação”; “academia”	AND
3 – Profissão e fenômeno associado	“educação física”; “ética profissional”; “dismorfia muscular”; “vigorexia”	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota: Bases consultadas: SciELO, LILACS, PubMed e Google Acadêmico. Filtros: 2011–2026; português e inglês. Data da busca: [inserir data].

3.3 Critérios de inclusão e exclusão

Os critérios de elegibilidade foram definidos previamente à seleção e estão sintetizados no Quadro 2. Em coerência com o método da revisão integrativa, admitiram-se estudos primários e revisões de diferentes tipos. As obras clássicas anteriores a 2011 e os textos de fundamentação teórica e metodológica foram utilizados como referencial teórico (seção 2) e não integram o corpus de resultados.

Quadro 2 – Critérios de elegibilidade dos estudos

Critérios de inclusão	Critérios de exclusão
Artigos científicos, revisões, dissertações, teses e trabalhos de conclusão de curso, além de documentos normativos e institucionais.	Estudos sobre uso terapêutico de EAA.
Publicados entre 2011 e 2026, em português ou inglês.	Publicações fora do recorte temporal ou idiomático.
Abordassem o uso de EAA no contexto de academias e musculação e/ou o papel ético-profissional do educador físico.	Produções sem dados empíricos, sem sistematização da literatura ou sem análise documental.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.4 Análise documental

Em complemento à revisão, foram analisados dois documentos normativos: a Resolução CONFEF nº 508/2023, que institui o Código de Ética Profissional vigente (CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 2023), e a Lei nº 9.696/1998, que regulamenta a profissão (BRASIL, 1998). A análise consistiu na leitura integral dos textos, na identificação dos dispositivos relativos à promoção da saúde, à vedação de práticas ilícitas, aos limites de competência e ao dever de informação ao beneficiário, e no confronto desses dispositivos com o contexto do uso de EAA.

3.5 Análise dos dados

Os dados foram analisados por meio de análise de conteúdo temática, conforme as três fases propostas por Bardin (2011): pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados com inferência e interpretação. Os dados dos estudos incluídos foram extraídos para uma matriz-síntese (Quadro 4) e organizados em quatro categorias temáticas correspondentes aos objetivos específicos: (A) prevalência e fatores motivacionais; (B) riscos à saúde; (C) responsabilidades ético-profissionais; e (D) limites entre orientação e conivência, incluindo a formação profissional. Os dados de prevalência receberam, ainda, tratamento descritivo simples

(valores mínimo, máximo, mediana e média), sem pretensão de meta-análise, dada a heterogeneidade metodológica dos estudos.

4 RESULTADOS

Esta seção apresenta os achados da revisão integrativa e da análise documental. Inicialmente, caracteriza-se o corpus analisado; em seguida, os achados são sistematizados em quatro categorias temáticas, derivadas da análise de conteúdo (BARDIN, 2011) e correspondentes aos objetivos específicos: (i) prevalência e fatores motivacionais; (ii) riscos à saúde; (iii) responsabilidades e deveres ético-profissionais; e (iv) limites entre orientação e conivência. Em coerência com o caráter de revisão, esta seção restringe-se à apresentação e à organização dos dados, reservando-se a interpretação crítica para a Discussão.

4.1 Caracterização do corpus analisado

O percurso de seleção seguiu as etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão, sintetizadas no Quadro 3. O corpus final foi composto por 24 documentos: 19 estudos científicos (10 estudos primários e 9 revisões e sínteses), 2 documentos normativos e 3 fontes institucionais e jornalística.

Quadro 3 – Fluxo de seleção dos estudos da revisão integrativa

Etapa	Descrição	Nº de registros
Identificação	Registros recuperados nas bases SciELO, LILACS, PubMed e Google Acadêmico, a partir dos descritores e operadores do Quadro 1.	[inserir]
Triagem	Remoção de duplicatas e exclusão por título e resumo (fora do tema, do recorte temporal ou sobre uso terapêutico).	[inserir]
Elegibilidade	Leitura na íntegra dos textos remanescentes e verificação dos critérios do Quadro 2.	[inserir]
Inclusão	Documentos que compuseram o corpus final da análise temática.	**24** (19 estudos científicos; 2 documentos normativos; 3 fontes institucionais e jornalística)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O Quadro 4 apresenta a matriz-síntese do corpus, com a indicação do tipo de documento, do foco ou da amostra, dos principais achados e do eixo temático predominante (A a D, conforme a seção 3.5).

Quadro 4 – Matriz-síntese do corpus analisado (n = 24)

Autor (ano)	Tipo de documento	Foco / amostra	Principais achados	Eixo
Abrahin, Souza e Ferreira (2013)	Revisão da literatura	Estudos brasileiros sobre uso de EAA	Prevalência entre 2,1% e 25,5%, conforme amostra e região.	A
Nogueira et al. (2013)	Revisão sistemática	Recursos ergogênicos em praticantes de academias brasileiras	Consumo de suplementos e de EAA exacerbado nesses espaços, sobretudo em algumas regiões.	A
Soler et al. (2013)	Estudo empírico	Vigorexia e dependência de exercício em frequentadores de academia e fisiculturistas	Comportamento compulsivo com o treino associa-se a práticas de risco, entre elas o uso de EAA.	A
Sagoe et al. (2014)	Meta-análise	Epidemiologia global do uso de EAA	Prevalência global ao longo da vida de 3,3% (homens, 6,4%; mulheres, 1,6%).	A
Pope Jr. et al. (2014)	Declaração científica (Endocrine Society)	Consequências adversas de substâncias para melhora de desempenho	Sistematiza as consequências clínicas adversas do uso de esteroides anabolizantes.	B
Solimini et al. (2017)	Revisão	Hepatotoxicidade do uso ilícito de EAA	Elevação de enzimas hepáticas, colestase, peliose hepática e, em casos extremos, tumores hepáticos.	B
Oliveira et al. (2018)	Estudo empírico	Frequência de uso e perfil dos usuários	Predomínio masculino; hipertrofia e estética como motivações centrais.	A
Bastos et al. (2019)	Estudo empírico	Estudantes e profissionais de Educação Física e Psicologia	Déficit de conhecimento sobre EAA.	D
Mattos et al. (2019)	Estudo empírico	Estudantes de Educação Física	Documenta a prevalência de uso entre os próprios estudantes.	D
Liu e Wu (2019)	Revisão	Risco cardiovascular associado aos EAA	Alterações lipídicas, hipertrofia ventricular, hipertensão, arritmias e aterosclerose; risco de infarto e AVC.	B
Machado et al. (2020)	Estudo empírico	Estudantes-fisiculturistas de cursos de graduação em Educação Física	Aprendizado sobre EAA em circuitos informais; dilema entre discurso técnico e prática.	D
Morato et al. (2020)	Estudo empírico	Praticantes de musculação em academias	Prevalência de 29%, mais elevada no público masculino.	A
Diniz (2021)	TCC (revisão)	Vigorexia e uso de anabolizantes em praticantes de musculação	Distorção da autoimagem como fator de risco para o consumo.	A

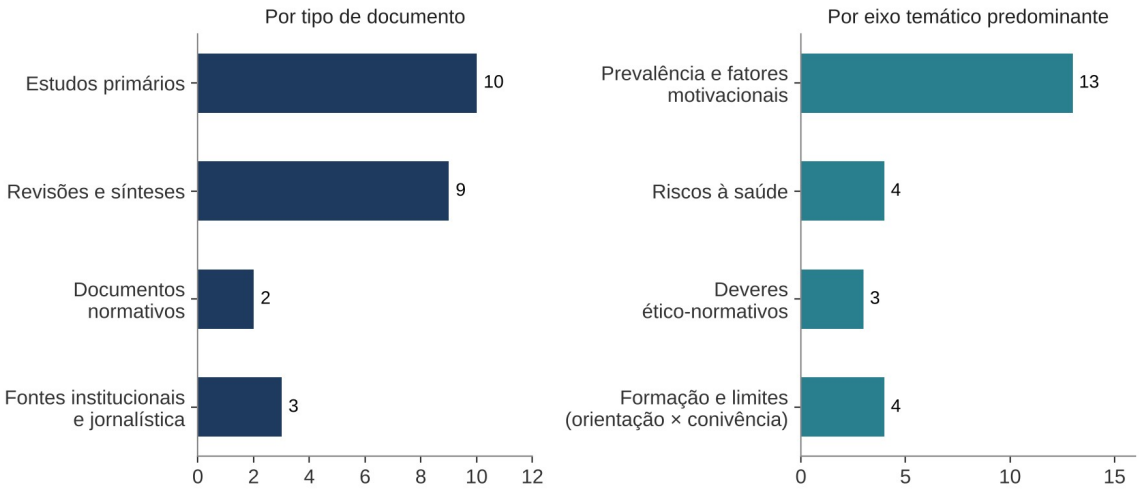
Autor (ano)	Tipo de documento	Foco / amostra	Principais achados	Eixo
Ferreira, Palma e Pasquim (2023)	Estudo qualitativo	Redução de danos entre praticantes de musculação usuários de esteroides	Redução de danos como “ética do não abandono”; abordagem moralizante afasta o usuário do cuidado.	D
Monteiro et al. (2023)	Estudo empírico	Praticantes de três academias	20,20% já fizeram ou faziam uso de EAA.	A
Júnior et al. (2024)	Estudo empírico	Praticantes de musculação	Prevalência de 14,48%; predomínio masculino; hipertrofia como objetivo principal.	A
Carmo et al. (2025)	Estudo empírico	257 participantes	16,73% relataram uso; predomínio na faixa de 31 a 50 anos.	A
Amorim et al. (2025)	Revisão de escopo	Dismorfia muscular e uso de EAA	Sintomas de dismorfia associam-se a maior propensão ao uso.	A
Mouzinho et al. (2025)	Revisão narrativa	Vigorexia, redes sociais e uso de EAA	Intensificação do transtorno pela pressão estética digital.	A
Lei nº 9.696/1998	Documento normativo	Regulamentação da profissão	Institui o Sistema CONFEF/CREFs.	C
CONFEF, Res. nº 508/2023	Documento normativo	Código de Ética Profissional	Deveres gerais de promoção da saúde e vedação de práticas ilícitas, sem diretriz específica para EAA.	C
CREF3/SC (2026)	Fonte institucional	Campanha de conscientização	Posicionamento institucional contra o uso não médico de EAA.	C
Brasil (2024)	Fonte institucional (Ministério da Saúde)	Boletim Epidemiológico	Uso indevido de EAA como problema de saúde pública.	B
Jornal da USP (2024)	Fonte jornalística	Levantamento da SBEM entre estudantes	Um em cada 16 estudantes já usou anabolizantes; aumentos de 39%, 67% e 84% por nível de ensino.	A

Fonte: Elaborado pelos autores (2026) com base na literatura revisada.

Nota: Eixos: A = prevalência e fatores motivacionais; B = riscos à saúde; C = deveres ético-normativos; D = formação e limites entre orientação e conivência.

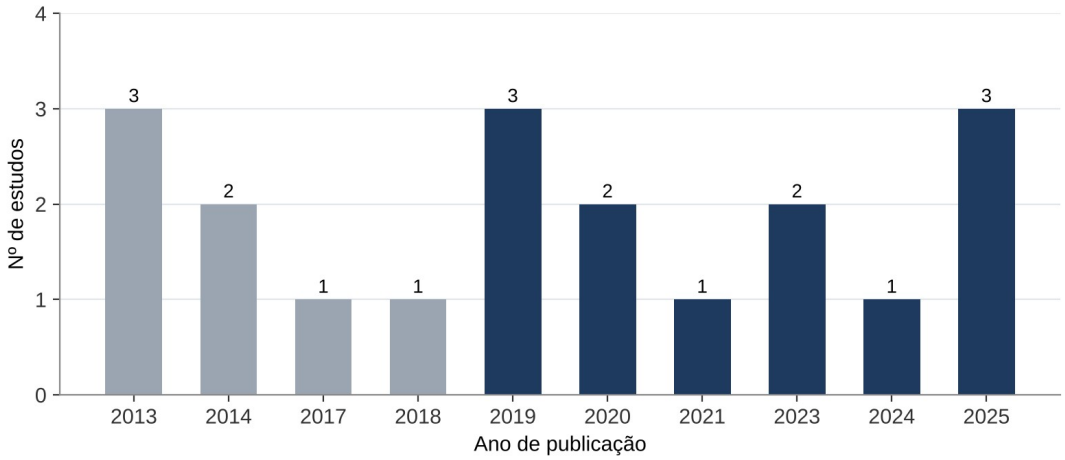
A caracterização do corpus revela duas tendências. Quanto ao eixo temático, 13 dos 24 documentos (54,2%) tratam de prevalência e fatores motivacionais, ao passo que apenas 4 (16,7%) abordam diretamente a formação profissional e os limites entre orientação e conivência (Gráfico 1). Quanto à época, 12 dos 19 estudos científicos (63,2%) foram publicados a partir de 2019, o que indica produção recente e em crescimento (Gráfico 4).

Gráfico 1 – Composição do corpus por tipo de documento e por eixo temático (n = 24)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026) com base no Quadro 4.

Gráfico 2 – Distribuição dos estudos científicos por ano de publicação (n = 19)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026) com base no Quadro 4.
Nota: Em cinza, estudos publicados até 2018; em azul, a partir de 2019.

4.2 Prevalência e fatores motivacionais do uso de EAA

Os estudos incluídos convergem para o reconhecimento de que o uso de EAA por praticantes de musculação no Brasil constitui fenômeno expressivo e persistente. Embora as taxas variem conforme o desenho metodológico, o perfil da amostra e a região investigada, os percentuais dos estudos empíricos recentes situam-se entre 14% e 29%. A revisão de Abrahin, Souza e Ferreira (2013) registrou amplitude de 2,1% a 25,5%, ao passo que estudos posteriores confirmaram patamares elevados: Morato et al. (2020) encontraram 29%; Monteiro et al. (2023), 20,20%; Carmo et al. (2025), 16,73%; e Júnior et al. (2024), 14,48%. A Tabela 1 reúne as estimativas de prevalência extraídas do corpus e o Gráfico 3 as compara.

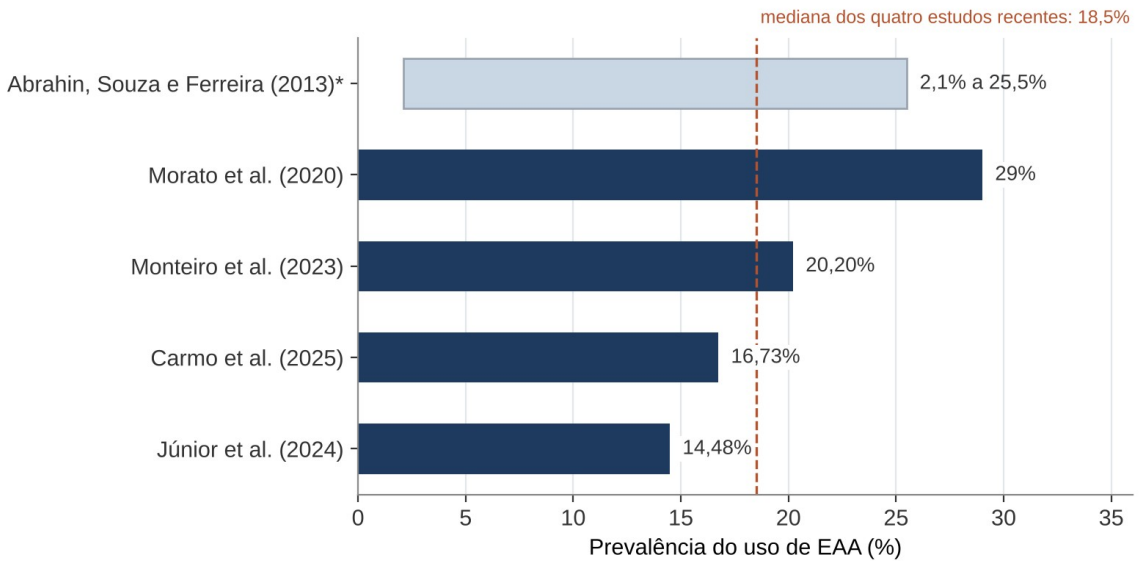
Tabela 1 – Prevalência do uso de EAA segundo os estudos do corpus

Estudo (ano)	Tipo	Contexto / amostra	Prevalência
Abrahin, Souza e Ferreira (2013)	Revisão	Estudos brasileiros	2,1% a 25,5%
Morato et al. (2020)	Empírico	Praticantes em academias	29%
Monteiro et al. (2023)	Empírico	Praticantes de três academias	20,20%
Carmo et al. (2025)	Empírico	257 participantes	16,73%
Júnior et al. (2024)	Empírico	Praticantes de musculação	14,48%
Sagoe et al. (2014)	Meta-análise	População geral, âmbito global	3,3% ao longo da vida (homens, 6,4%; mulheres, 1,6%)

Fonte: Elaborada pelos autores (2026) com base na literatura revisada.

Nota: Nogueira et al. (2013) e Oliveira et al. (2018) compõem o corpus, mas não constam da tabela por não terem tido prevalências pontuais extraídas. O dado de Sagoe et al. (2014) refere-se à população geral e serve apenas de referência comparativa.

Gráfico 3 – Prevalência do uso de EAA entre praticantes de musculação em estudos brasileiros



* Amplitude de prevalências sintetizada em revisão; não representa estimativa pontual.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026) com base na Tabela 1.

O tratamento descritivo das quatro estimativas pontuais recentes (Tabela 2) mostra amplitude de 14,52 pontos percentuais, mediana de 18,47% e média simples de 20,10%. Trata-se de medidas exploratórias, sem ponderação pelo tamanho amostral, que não devem ser tomadas como estimativa nacional, mas que evidenciam o patamar em que o fenômeno se apresenta.

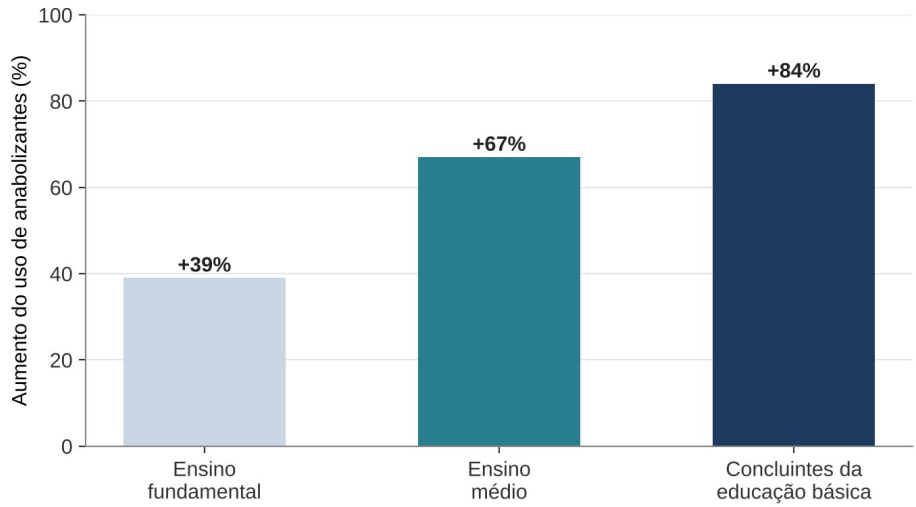
Tabela 2 – Estatísticas descritivas das prevalências recentes (n = 4 estudos)

Medida	Valor
Mínimo (Júnior et al., 2024)	14,48%
Máximo (Morato et al., 2020)	29,00%
Amplitude	14,52 p.p.
Mediana	18,47%
Média simples	20,10%

Fonte: Elaborada pelos autores (2026) com base na Tabela 1.
Nota: p.p. = pontos percentuais. Valores calculados sem ponderação amostral.

Os dados evidenciam ainda um deslocamento preocupante do consumo para faixas etárias mais jovens. Levantamento noticiado pelo Jornal da USP (2024) aponta que um em cada dezesseis estudantes brasileiros já utilizou anabolizantes, com aumentos de 39% entre estudantes do ensino fundamental, 67% no ensino médio e 84% entre concluintes da educação básica (Gráfico 4). A variação das taxas é atribuída à complexidade metodológica do objeto, que envolve questionários autoaplicáveis, subnotificação por receio de julgamento e diversidade dos perfis amostrais, admitindo-se que os percentuais representem estimativas conservadoras.

Gráfico 4 – Aumento do uso de anabolizantes entre estudantes brasileiros, por nível de ensino



Fonte: Elaborado pelos autores (2026) com base em Jornal da USP (2024).
Nota: Aumento relativo desde 1996, conforme levantamento da SBEM noticiado pelo veículo.

Quanto aos fatores motivacionais, a literatura é consensual ao indicar que, entre frequentadores comuns de academia, o desempenho competitivo raramente constitui a razão principal do consumo. Predominam motivações de ordem estética e psicossocial: a busca por hipertrofia e por um corpo idealizado (OLIVEIRA et al., 2018), a pressão social e cultural do culto ao corpo (IRIART; CHAVES; ORLEANS,

2009) e a dismorfia muscular, ou vigorexia, transtorno da imagem corporal caracterizado pela percepção distorcida de insuficiência muscular, frequentemente associado ao uso de EAA (CAMARGO et al., 2008; SOLER et al., 2013; AMORIM et al., 2025; MOUZINHO et al., 2025). Esses determinantes, de natureza multifatorial, ajudam a explicar por que o consumo se dissemina em ambiente não competitivo e se instala como prática socializada no cotidiano das academias.

4.3 Riscos à saúde associados ao uso não médico de EAA

A análise da produção científica recente permitiu sistematizar os riscos à saúde decorrentes do uso não médico de EAA, caracterizado pela autoadministração de dosagens suprafisiológicas — frequentemente muito superiores às utilizadas com finalidade terapêutica — em ciclos combinados e sem acompanhamento clínico (WU, 1997; ABRAHIN; SOUZA; FERREIRA, 2013). Os efeitos adversos documentados distribuem-se por diferentes sistemas orgânicos e variam conforme a via de administração: compostos orais 17-alquilados estão associados a maior hepatotoxicidade, enquanto os ésteres injetáveis, embora de menor impacto hepático direto, não estão isentos de riscos cardiovasculares, endócrinos e psiquiátricos (HARTGENS; KUIPERS, 2004; KICMAN, 2008). O Quadro 3 organiza os principais riscos por sistema afetado.

Quadro 5 – Riscos à saúde associados ao uso não médico de EAA, por sistema

Sistema	Principais efeitos documentados	Referências
Cardiovascular	Hipertensão, alterações do perfil lipídico, hipertrofia ventricular, arritmias e maior risco de infarto e AVC.	Liu e Wu (2019); Van Amsterdam, Opperhuizen e Hartgens (2010); Pope Jr. et al. (2014)
Hepático	Hepatotoxicidade, especialmente com compostos orais 17-alquilados; elevação enzimática, colestase e peliose hepática.	Solimini et al. (2017); Kicman (2008)
Endócrino / reprodutivo	Supressão do eixo hormonal, atrofia testicular, ginecomastia e infertilidade.	Wu (1997); Hartgens e Kuipers (2004)
Psiquiátrico / comportamental	Agressividade, alterações de humor, dependência, abstinência e consequências psiquiátricas de longo prazo.	Kanayama, Hudson e Pope Jr. (2008)
Dermatológico	Acne severa, pele oleosa e aceleração da calvície em predispostos.	Kicman (2008)
Crescimento (adolescentes)	Fechamento prematuro das placas epifisárias e redução da estatura final.	Van Amsterdam, Opperhuizen e Hartgens (2010)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026) com base na produção científica revisada.

O conjunto das evidências reforça que o uso não médico de EAA extrapola a dimensão estética pretendida pelos usuários e configura risco sistêmico à saúde, corroborando a classificação do fenômeno como questão de saúde pública (BRASIL, 2024). Distingue-se, portanto, o uso terapêutico — legítimo e sob prescrição médica — do uso estético não supervisionado, este último desprovido de respaldo científico e associado à ampla gama de efeitos deletérios aqui sistematizados.

4.4 Responsabilidades e deveres ético-profissionais do educador físico

A análise documental do Código de Ética Profissional (Resolução CONFEF nº 508/2023) e da Lei nº 9.696/1998 evidenciou que o arcabouço normativo estabelece deveres gerais orientados à promoção da saúde, ao respeito à dignidade do beneficiário, à vedação de práticas ilícitas e à atuação dentro dos limites de competência da profissão. Contudo, tais dispositivos não contemplam diretriz específica sobre a conduta a ser adotada diante da identificação ou suspeita de uso de EAA, o que caracteriza lacuna normativa relevante. O Quadro 6 relaciona os deveres extraídos do arcabouço normativo à sua aplicação no contexto do uso de anabolizantes.

Quadro 6 – Deveres ético-profissionais e sua aplicação ao contexto do uso de EAA

Dever / princípio normativo	Interpretação dos autores quanto à aplicação ao uso de EAA
Promoção da saúde e integridade do beneficiário	Dever de educar sobre os riscos do uso não médico e de priorizar a saúde do praticante acima de objetivos estéticos.
Vedação de práticas ilícitas e do exercício ilegal	Proibição de prescrever, indicar protocolos ou fornecer substâncias, atos que extrapolam a competência da profissão.
Atuação nos limites de competência	Dever de encaminhar a profissionais habilitados (médico, nutricionista, psicólogo) quando identificado o uso ou o risco.
Ausência de diretriz específica sobre EAA	Lacuna normativa: o Código não define conduta objetiva diante da suspeita de uso, gerando insegurança na prática.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026) com base na análise documental do Sistema CONFEF/CREFs.

A literatura evidencia, ademais, que essa lacuna normativa é agravada por fragilidades na formação acadêmica. Bastos et al. (2019) identificaram déficit de conhecimento sobre EAA entre estudantes e profissionais de Educação Física, e Machado et al. (2020) descreveram o dilema vivido por estudantes-fisiculturistas, revelando ambiguidade entre o discurso técnico-científico e a prática cotidiana. Delineia-se, assim, um cenário em que o dever ético existe em termos gerais, mas carece de tradução operacional e de preparo formativo que o sustente.

4.5 Limites entre orientação e conivência

A quarta categoria temática reúne os achados relativos às situações-limite que tensionam a fronteira entre a orientação responsável e a conivência. A literatura revisada permitiu tipificar três configurações recorrentes: a prescrição velada, a omissão diante do uso e o uso próprio pelo profissional, cada qual com implicações éticas distintas, sintetizadas no Quadro 7.

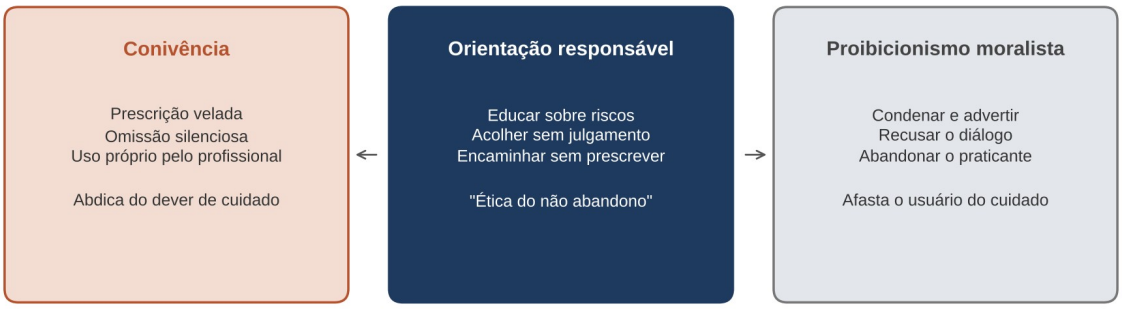
Quadro 7 – Situações-limite entre orientação e conivência

Situação-limite	Descrição	Possível implicação ética
Prescrição velada	Indicação indireta de substâncias, dosagens ou protocolos, dissimulada como orientação de treino.	Violação ética e exercício ilegal; abdicação do dever de cuidado por conveniência.
Omissão diante do uso	Silêncio ou inobservância ante sinais evidentes de uso, sem orientar ou encaminhar.	Negligência do dever de promoção da saúde; conivência por omissão.
Uso próprio pelo profissional	O próprio educador físico faz uso de EAA, tornando-se referência e legitimando a prática perante o aluno.	Contradição com o dever de exemplo e de promoção da saúde; comprometimento da confiança profissional.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026) com base na literatura revisada.

Em contraponto aos extremos da permissividade e do proibicionismo moralista, a literatura aponta um terceiro caminho: a orientação responsável fundamentada na lógica da redução de danos. Ferreira, Palma e Pasquim (2023) descrevem essa abordagem menos como um conjunto de técnicas de “uso mais seguro” e mais como uma ética do não abandono, que consiste em manter o vínculo, evitar o juízo moral paralisante e criar condições para que o usuário busque ajuda qualificada. Nesse recorte, ao educador físico não compete prescrever nem monitorar parâmetros laboratoriais, mas atuar no plano da educação em saúde e do encaminhamento responsável, funcionando como elo entre o praticante e o sistema formal de cuidado. A Figura 1 sintetiza esse espectro.

Figura 1 – Espectro de condutas diante do uso de EAA: conivência, orientação responsável e proibicionismo moralista



Fonte: Elaborada pelos autores (2026) com base em Ferreira, Palma e Pasquim (2023).

4.6 Síntese dos resultados

Os achados articulam-se em quatro eixos convergentes, apresentados no Quadro 8 em correspondência com os objetivos específicos. Esses achados fornecem a base empírica e documental que será interpretada criticamente na seção seguinte.

Quadro 8 – Síntese dos resultados por objetivo específico

Objetivo específico	Principais achados	Seção
a) Prevalência e fatores motivacionais	Prevalência expressiva e heterogênea (majoritariamente entre 14% e 29%; mediana de 18,47%), com indícios de precocidade do consumo; motivações estéticas, pressão social e dismorfia muscular.	4.2
b) Riscos à saúde	Efeitos cardiovasculares, hepáticos, endócrinos, psiquiátricos, dermatológicos e sobre o crescimento, configurando questão de saúde pública.	4.3
c) Deveres ético-profissionais	Deveres gerais de promoção da saúde, vedação de práticas ilícitas e atuação nos limites de competência, sem diretriz específica para EAA; lacuna agravada por fragilidades na formação.	4.4
d) Limites entre orientação e conivência	Três situações-limite (prescrição velada, omissão e uso próprio); redução de danos e encaminhamento responsável como via ética intermediária.	4.5

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5 DISCUSSÃO

Esta seção interpreta criticamente os achados apresentados nos Resultados, articulando-os com a literatura científica e com os documentos normativos do Sistema CONFEF/CREFs, a fim de responder ao problema de pesquisa: de que forma tais fontes definem o papel e os limites éticos do profissional de Educação Física diante do uso de anabolizantes por praticantes de musculação. A discussão organiza-se em torno dos quatro eixos temáticos da pesquisa, convergindo, ao final, para o tensionamento do dilema central entre orientar e ser conivente.

5.1 A magnitude do fenômeno e seus determinantes

A convergência das prevalências identificadas — majoritariamente entre 14% e 29% (MORATO et al., 2020; MONTEIRO et al., 2023; JÚNIOR et al., 2024; CARMO et al., 2025) — permite afirmar que o uso de EAA na musculação não constitui desvio marginal, mas prática estruturalmente presente no cotidiano das academias. A leitura conjunta desses dados com a revisão de Abrahin, Souza e Ferreira (2013) sugere que, mais do que oscilação metodológica, a amplitude das taxas expressa a própria natureza clandestina do comportamento, o que autoriza tratar os percentuais como estimativas conservadoras. Nesse sentido, o dado epidemiológico deixa de ser mera contextualização e passa a fundamentar a urgência ética: o profissional de Educação Física convive, estatisticamente, com usuários em praticamente toda turma que atende.

Em perspectiva internacional, a prevalência global ao longo da vida estimada por Sagoe et al. (2014) para a população geral (3,3%) é substancialmente inferior à observada nos estudos brasileiros com praticantes de musculação, o que reforça que a academia é um contexto de exposição concentrada. A ressalva é que se comparam populações distintas, e a comparação serve apenas para dimensionar o fenômeno.

O ponto de maior densidade interpretativa, contudo, reside nos determinantes motivacionais. Ao contrário do esporte de rendimento, em que o uso se orienta à performance competitiva, entre frequentadores comuns o consumo é movido por pressão estética, culto ao corpo e dismorfia muscular (IRIART; CHAVES; ORLEANS, 2009; OLIVEIRA et al., 2018; SOLER et al., 2013; AMORIM et al., 2025). Esse deslocamento tem implicação direta para a atuação profissional: se a motivação é psicossocial e, por vezes, patológica — como na vigorexia —, a resposta do educador físico não pode limitar-se à informação técnica sobre riscos, mas deve reconhecer o sofrimento e a distorção de imagem que sustentam a demanda, articulando-se ao encaminhamento psicológico e médico. O crescimento do uso entre adolescentes

(JORNAL DA USP, 2024) agrava esse quadro, deslocando a responsabilidade também para o âmbito escolar e preventivo.

5.2 Os riscos à saúde como fundamento do dever de cuidado

A sistematização dos riscos à saúde — cardiovasculares, hepáticos, endócrinos e psiquiátricos (HARTGENS; KUIPERS, 2004; KANAYAMA; HUDSON; POPE JR., 2008; SOLIMINI et al., 2017; LIU; WU, 2019; POPE JR. et al., 2014) — fornece o substrato objetivo que converte o problema de um plano meramente estético para o campo da saúde pública (BRASIL, 2024). Essa transposição é decisiva para a argumentação ética: é justamente porque o uso não médico produz dano concreto e documentado que se pode afirmar a existência de um dever de cuidado do profissional, e não apenas uma faculdade discricionária. A gravidade e a irreversibilidade de parte desses efeitos deslocam a questão do juízo moral sobre o corpo alheio para o terreno da prevenção de agravos.

Ao mesmo tempo, a distinção farmacológica entre uso terapêutico e uso estético suprafisiológico não supervisionado (KICMAN, 2008; WU, 1997) delimita com precisão o objeto da preocupação ética: não se trata de condenar a substância em si — legítima sob prescrição —, mas a autoadministração suprafisiológica sem acompanhamento. Essa precisão é importante porque afasta o discurso moralizante e recoloca a discussão em bases técnicas, nas quais o educador físico tem legitimidade para intervir por meio da educação em saúde, sem, contudo, arvorar-se em competências que não lhe pertencem.

5.3 A lacuna normativa e a insuficiência da formação

O confronto entre os achados empíricos e a análise documental revela a principal tensão do estudo: enquanto a realidade das academias exige respostas concretas, o Código de Ética Profissional (Resolução CONFEF nº 508/2023) e a Lei nº 9.696/1998 dispõem apenas de deveres genéricos — promoção da saúde, vedação de práticas ilícitas e atuação nos limites de competência —, sem endereçar objetivamente a conduta esperada diante do uso de EAA. Argumenta-se, aqui, que essa lacuna não significa ausência de dever: os princípios gerais, quando interpretados sistematicamente, já impõem ao profissional uma atuação proativa de orientação e encaminhamento. O que falta não é o fundamento ético, mas a sua tradução em protocolos operacionais que reduzam a insegurança do profissional no momento da decisão.

Essa fragilidade normativa é potencializada pelo déficit formativo documentado por Bastos et al. (2019) e pelo dilema descrito por Machado et al. (2020) entre

estudantes-fisiculturistas. A convergência desses achados sugere um círculo vicioso: a ausência de diretriz clara desestimula a abordagem do tema na graduação, e a lacuna formativa, por sua vez, perpetua a insegurança e a omissão na prática. Romper esse ciclo exige ação em duas frentes complementares: a inclusão explícita do tema nos currículos de Educação Física e a edição, pelo Sistema CONFEF/CREFs, de orientações técnicas específicas — movimento já esboçado em campanhas de conscientização como a do CREF3/SC (2026), ainda que insuficiente enquanto não se converta em protocolo.

5.4 Entre orientar e ser conivente: o tensionamento do dilema ético

O núcleo do problema de pesquisa reside na tipificação das situações-limite — prescrição velada, omissão e uso próprio pelo profissional. A prescrição velada configura a violação mais evidente, pois soma à infração ética o exercício ilegal de competência alheia; a omissão, embora aparentemente neutra, revela-se igualmente grave, por abdicar do dever de cuidado sob a aparência de respeito à autonomia; e o uso próprio compromete o dever de exemplo e corrói a confiança que sustenta a relação profissional-aluno. A análise dessas três configurações demonstra que a conivência não se manifesta apenas no ato comissivo, mas também — e sobretudo — no silêncio.

O tensionamento decisivo, contudo, emerge da falsa oposição entre permissividade e proibicionismo. Como aponta a perspectiva da redução de danos (FERREIRA; PALMA; PASQUIM, 2023), tanto a conivência — que abandona o usuário por conveniência — quanto o proibicionismo moralista — que o abandona por julgamento — podem falhar com o mesmo dever de cuidado. A saída ética, nesta interpretação, não estaria em nenhum dos extremos, mas em um terceiro caminho: a orientação responsável, que os referidos autores designam como ‘ética do não abandono’ — manter o vínculo, evitar o juízo moral paralisante e criar condições para o encaminhamento qualificado. Cabe registrar que a transposição da lógica de redução de danos ao uso de EAA ainda carece de protocolos consolidados, de modo que o presente trabalho a assume como referencial interpretativo e proposição de conduta, e não como norma estabelecida. Nesse enquadramento, o educador físico atuaria como elo entre o praticante e o sistema formal de cuidado — educando sobre riscos, acolhendo sem legitimar e encaminhando sem prescrever.

5.5 Proposição de conduta profissional (proposta dos autores)

A partir da análise da literatura e do arcabouço normativo, e a título de proposição dos autores, e não de protocolo oficial, sugere-se um roteiro de conduta

profissional diante da identificação ou suspeita de uso não médico de EAA, organizado em sete passos complementares e não hierárquicos. O Quadro 9 apresenta cada passo acompanhado de sua fundamentação.

Quadro 9 – Roteiro de conduta profissional diante do uso de EAA e sua fundamentação

Passo	Conduta proposta	Fundamentação
1	Observar e reconhecer sinais no cotidiano do treino (alterações abruptas de composição corporal, de humor ou dermatológicas), sem emitir diagnóstico, que não compete ao educador físico.	Kicman (2008), quanto aos sinais dermatológicos como indicadores externos; Res. CONFEF nº 508/2023, quanto aos limites de competência.
2	Acolher o praticante sem juízo moralizante, reconhecendo as motivações estéticas e psicossociais envolvidas e preservando o vínculo profissional.	Ferreira, Palma e Pasquim (2023), “ética do não abandono”; Miller e Rollnick (2013), escuta empática e entrevista motivacional.
3	Informar, de forma técnica e baseada em evidências, sobre os riscos à saúde associados ao uso não supervisionado, em linguagem acessível.	Hartgens e Kuipers (2004); Kanayama, Hudson e Pope Jr. (2008); Pope Jr. et al. (2014); Res. CONFEF nº 508/2023, dever de informar o beneficiário.
4	Reafirmar, com transparência, os limites legais e éticos da profissão, abstendo-se de recomendar, indicar dosagens, montar “ciclos” ou sugerir fornecedores.	Res. CONFEF nº 508/2023, vedações; Lei nº 9.696/1998.
5	Encaminhar a profissionais legalmente habilitados (médico, endocrinologista, nutricionista e psicólogo) e à rede de atenção à saúde, sempre que necessário.	Res. CONFEF nº 508/2023, atuação nos limites de competência; Ferreira, Palma e Pasquim (2023).
6	Ajustar e conduzir o programa de treino de modo seguro, alinhado às condições de saúde do praticante e orientado por resultados sustentáveis.	Res. CONFEF nº 508/2023, programa de atividades conforme as condições de saúde do indivíduo.
7	Registrar as orientações prestadas e articular-se com a rede de cuidado, mantendo canal de diálogo aberto e acompanhamento contínuo.	Res. CONFEF nº 508/2023, dever de manter o beneficiário informado; Ferreira, Palma e Pasquim (2023), manutenção do vínculo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota: Onde a fundamentação é normativa, trata-se de interpretação sistemática dos dispositivos pelos autores, e não de prescrição literal do Código de Ética.

Trata-se de proposição interpretativa, coerente com a lógica da “ética do não abandono” (FERREIRA; PALMA; PASQUIM, 2023), que demanda validação futura e, idealmente, incorporação a diretrizes técnicas do Sistema CONFEF/CREFs.

6 CONCLUSÃO

O presente estudo analisou, a partir da revisão da literatura científica e dos documentos normativos do Sistema CONFEF/CREFs, o papel e os limites éticos do profissional de Educação Física frente ao uso de EAA por praticantes de musculação. Os quatro objetivos específicos foram atendidos, conforme sintetizado a seguir.

Quanto à prevalência e aos fatores motivacionais, o uso de EAA mostrou-se expressivo e heterogêneo, majoritariamente entre 14% e 29% nos estudos recentes, com indícios de precocidade do consumo e motivação predominantemente estética e psicossocial, e não competitiva. Quanto aos riscos, os efeitos cardiovasculares, hepáticos, endócrinos e psiquiátricos documentados conferem ao fenômeno o estatuto de questão de saúde pública. No plano normativo, o Código de Ética estabelece deveres gerais de promoção da saúde e de vedação de práticas ilícitas, mas não traz diretriz específica sobre os EAA, lacuna agravada por fragilidades na formação. Por fim, a prescrição velada, a omissão e o uso próprio pelo profissional delimitam a fronteira entre orientação e conivência.

Em resposta ao problema de pesquisa, conclui-se que a literatura e os dispositivos normativos, ainda que de forma indireta, permitem interpretar para o educador físico um papel de atuação proativa, centrado na educação em saúde e no encaminhamento responsável. Seus limites éticos situam-se entre a vedação da conivência e a proibição de extrapolar suas competências. Entre eles delineia-se a orientação responsável, fundamentada em evidências e na “ética do não abandono”, que rejeita tanto a permissividade quanto o proibicionismo moralista. Orientar sobre riscos, portanto, não configura conivência, mas expressão do compromisso ético da profissão.

Como contribuição, o trabalho sistematiza o quadro epidemiológico, clínico e ético-normativo do tema e propõe um roteiro de conduta fundamentado (Quadro 9), oferecendo subsídios ao aprimoramento curricular e à eventual construção de protocolos pelo Sistema CONFEF/CREFs.

Reconhecem-se limitações. A seleção do corpus, de caráter intencional e sem protocolo registrado previamente, pode não ter esgotado a produção sobre o tema; os achados restringem-se à literatura disponível e ao recorte temporal e idiomático adotado (2011 a 2026, português e inglês), sem dados primários; a heterogeneidade metodológica e a subnotificação impedem generalizações sobre a magnitude real do fenômeno; e é escassa a produção que articula diretamente o uso de EAA à normatização ético-profissional.

Sugere-se, para pesquisas futuras, a realização de estudos de campo quali-quantitativos sobre a percepção e a conduta de profissionais de Educação Física

diante da suspeita de uso de EAA; a investigação do preparo curricular dos cursos de graduação; a avaliação do impacto das campanhas de conscientização; e a validação do roteiro proposto. Recomenda-se, ainda, que o Sistema CONFEF/CREFs avance na elaboração de orientações técnicas claras que traduzam os deveres éticos gerais em diretrizes operacionais.

REFERÊNCIAS

ABRAHIN, O. S. C.; SOUZA, T. S. M.; FERREIRA, L. G. Prevalência do uso e conhecimento de esteroides anabolizantes entre praticantes de musculação. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, São Paulo, v. 19, n. 1, p. 28-32, 2013.

ALMEIDA, F. E. Esteróides anabolizantes: história, mecanismos de funcionamento e efeitos colaterais. **Revista Brasileira de Fisiologia do Exercício**, v. 9, n. 4, 2010.

AMORIM, D. R. S. G. et al. Dismorfia muscular e o uso de esteroides anabolizantes: uma revisão de escopo. **Brazilian Medical Students**, v. 10, 2025.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BASTOS, F. B. et al. Investigação na formação de profissionais de Educação Física e Psicologia revela déficit no conhecimento sobre esteroides anabólico-androgênicos. **Pensar a Prática**, Goiânia, v. 22, 2019.

BRASIL. **Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1998**. Dispõe sobre a regulamentação da Profissão de Educação Física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física. Brasília, DF: Presidência da República, 1998.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Uso indevido de esteroides anabolizantes e outros produtos com finalidade estética. **Boletim Epidemiológico**, Brasília, 2024.

CAMARGO, T. P. P. de et al. Vigorexia: revisão dos aspectos atuais deste distúrbio de imagem corporal. **Revista Brasileira de Psicologia do Esporte**, v. 2, n. 1, p. 1-15, 2008.

CARMO, C. B. M. et al. Uso de anabolizantes por praticantes de musculação e as implicações na saúde. **Revista JRG**, 2025.

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. **Resolução nº 307, de 9 de novembro de 2015**. Dispõe sobre o Código de Ética dos Profissionais de Educação Física registrados no Sistema CONFEF/CREFs. Diário Oficial da União, Brasília, 2015.

CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. **Resolução nº 508, de 6 de outubro de 2023**. Dispõe sobre o Código de Ética Profissional do Sistema CONFEF/CREFs. Rio de Janeiro: CONFEF, 2023.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 3ª REGIÃO (CREF3/SC). **CREF3/SC lança série de conteúdos para alertar sobre os perigos do uso de anabolizantes**. Florianópolis: CREF3/SC, 5 ago. 2026. Disponível em: https://crefsc.org.br/cref3-sc-lanca-serie-de-conteudos-para-alertar-sobre-os-perigos-do-uso-de-anabolizantes/. Acesso em: 21 set. 2026.

DINIZ, L. M. **Vigorexia**: uma revisão acerca da relação entre o transtorno de vigorexia e o uso de anabolizantes em praticantes de musculação. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) – Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2021.

FERREIRA, T. C.; PALMA, A.; PASQUIM, H. M. Redução de danos entre praticantes de musculação que consomem esteroides. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 32, n. 3, e220585, 2023.

HARTGENS, F.; KUIPERS, H. Effects of androgenic-anabolic steroids in athletes. **Sports Medicine**, v. 34, n. 8, p. 513-554, 2004.

IRIART, J. A. B.; CHAVES, J. C.; ORLEANS, R. G. Culto ao corpo e uso de anabolizantes entre praticantes de musculação. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 25, n. 4, p. 773-782, 2009.

JORNAL DA USP. **O culto ao corpo leva cada vez mais jovens ao consumo de anabolizantes**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 23 ago. 2024. Disponível em: https://jornal.usp.br/campus-ribeirao-preto/o-culto-ao-corpo-leva-cada-vez-mais-jovens-ao-consumo-de-anabolizantes/. Acesso em: 21 set. 2026.

JÚNIOR, C. O. et al. Fatores sociodemográficos, perfil dos usuários e implicações do uso de esteroides anabolizantes androgênicos por praticantes de musculação. **Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício**, v. 18, n. 149, 2024.

KANAYAMA, G.; HUDSON, J. I.; POPE JR., H. G. Long-term psychiatric and medical consequences of anabolic-androgenic steroid abuse: a looming public health concern? **Drug and Alcohol Dependence**, v. 98, n. 1-2, p. 1-12, 2008.

KANAYAMA, G.; POPE JR., H. G. History and epidemiology of anabolic androgens in athletes and non-athletes. **Molecular and Cellular Endocrinology**, v. 464, p. 4-13, 2018.

KICMAN, A. T. Pharmacology of anabolic steroids. **British Journal of Pharmacology**, v. 154, n. 3, p. 502-521, 2008.

KOCHAKIAN, C. D.; MURLIN, J. R. The effect of male hormone on the protein and energy metabolism of castrate dogs. **Journal of Nutrition**, v. 10, n. 4, p. 437-459, 1936.

LIU, J. D.; WU, Y. Q. Anabolic-androgenic steroids and cardiovascular risk. **Chinese Medical Journal**, v. 132, n. 18, p. 2229-2236, 2019.

MACHADO, E. P. et al. Anabolizantes na graduação em Educação Física: um estudo sobre o dilema de estudantes-fisiculturistas. **Jornal de Pedagogia e Educação**, v. 8, 2020.

MATTOS, P. H. F. et al. Uso de esteroides anabolizantes em estudantes de Educação Física. **Revista Brasileira de Nutrição Esportiva**, 2019.

MILLER, W. R.; ROLLNICK, S. **Motivational interviewing**: helping people change. 3. ed. New York: Guilford Press, 2013.

MONTEIRO, D. A. et al. Uso de anabolizantes em praticantes de atividade física em academias. **Revista Científica do CRF-BA**, v. 1, 2023.

MORATO, L. G. et al. Prevalência do uso de anabolizantes por praticantes de musculação em academias. **Revista Farol**, 2020.

MOUZINHO, L. F. et al. Relações entre vigorexia e uso de esteroides anabolizantes. **Semina: Ciências Sociais e Humanas**, 2025.

NOGUEIRA, F. R. de S. et al. Prevalência do uso e efeitos de recursos ergogênicos por praticantes de musculação nas academias brasileiras: uma revisão sistemática. **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, v. 18, n. 1, p. 16-30, 2013.

OLIVEIRA, L. L. et al. Fatores sociodemográficos, perfil dos usuários e os motivos do uso de esteroides anabolizantes por praticantes de musculação. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 40, n. 3, p. 314-320, 2018.

POPE JR., H. G. et al. Adverse health consequences of performance-enhancing drugs: an Endocrine Society scientific statement. **Endocrine Reviews**, v. 35, n. 3, p. 341-375, 2014.

SAGOE, D. et al. The global epidemiology of anabolic-androgenic steroid use: a meta-analysis and meta-regression analysis. **Annals of Epidemiology**, v. 24, n. 5, p. 383-398, 2014.

SOLER, P. T. et al. Vigorexia e níveis de dependência de exercício em frequentadores de academias e fisiculturistas. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 19, n. 4, p. 246-250, 2013.

SOLIMINI, R. et al. Hepatotoxicity associated with illicit use of anabolic androgenic steroids in doping. **European Review for Medical and Pharmacological Sciences**, v. 21, n. 1, p. 7-16, 2017.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein**, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102-106, 2010.

STARLING, E. H. The Croonian Lectures on the chemical correlation of the functions of the body. **The Lancet**, v. 166, n. 4285, p. 339-342, 1905.

VAN AMSTERDAM, J.; OPPERHUIZEN, A.; HARTGENS, F. Adverse health effects of anabolic-androgenic steroids. **Regulatory Toxicology and Pharmacology**, v. 57, n. 1, p. 117-123, 2010.

WHITTEMORE, R.; KNAFL, K. The integrative review: updated methodology. **Journal of Advanced Nursing**, v. 52, n. 5, p. 546-553, 2005.

WU, F. C. W. Endocrine aspects of anabolic steroids. In: YESALIS, C. E. (ed.). **Anabolic steroids in sport and exercise**. Champaign: Human Kinetics, 1997. p. 73-93.

APÊNDICE A – MODELO DE ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO ANÔNIMO

(instrumento proposto, não aplicado nesta pesquisa)

Nota: este instrumento é apresentado como proposta para eventual aplicação futura em pesquisa de campo, condicionada à prévia submissão e aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Não foi aplicado no presente estudo, de natureza de revisão.

Termo de consentimento (leitura prévia): declaro estar ciente dos objetivos da pesquisa e concordo em participar de forma voluntária e anônima. ( ) Li e concordo em participar.

Bloco I — Perfil sociodemográfico

Idade: _____ anos

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino ( ) Outro ( ) Prefiro não informar

Cor/raça autodeclarada: ( ) Branca ( ) Preta ( ) Parda ( ) Amarela ( ) Indígena

Escolaridade: ( ) Fundamental ( ) Médio ( ) Superior incompleto ( ) Superior completo ( ) Pós-graduação

Ocupação atual: _____

Bloco II — Prática de musculação e hábitos de treino

Tempo de prática de musculação: ( ) Menos de 6 meses ( ) 6 a 12 meses ( ) 1 a 3 anos ( ) Mais de 3 anos

Frequência semanal de treino: ( ) 1 a 2 vezes ( ) 3 a 4 vezes ( ) 5 a 6 vezes ( ) Todos os dias

Faz uso de suplementos alimentares? ( ) Sim ( ) Não. Se sim, quais: _____

Bloco III — Uso de esteroides anabolizantes androgênicos (EAA)

As perguntas a seguir referem-se ao uso não médico de anabolizantes (sem prescrição e acompanhamento médico). Responda com sinceridade; lembre-se de que o questionário é anônimo.

Você já fez ou faz uso de EAA? ( ) Nunca usei ( ) Já usei, mas parei ( ) Faço uso atualmente

Se já usou, com que idade iniciou o uso? _____ anos ( ) Não se aplica

Como teve acesso à substância? ( ) Farmácia ( ) Academia ( ) Internet ( ) Amigos/conhecidos ( ) Outro: _____ ( ) Não se aplica

Quem indicou ou orientou o uso? ( ) Médico ( ) Educador físico ( ) Amigos ( ) Própria decisão ( ) Internet/redes sociais ( ) Outro: _____ ( ) Não se aplica

Realiza ou realizou acompanhamento médico durante o uso? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não se aplica

Bloco IV — Motivações e percepção da imagem corporal

Qual a principal motivação para o uso (ou para o possível uso) de EAA? ( ) Aumentar a massa muscular ( ) Melhorar a aparência/estética ( ) Pressão social ou estética ( ) Desempenho esportivo ( ) Outro: _____ ( ) Não se aplica

Você se sente satisfeito(a) com o seu corpo atualmente? ( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Indiferente ( ) Insatisfeito ( ) Muito insatisfeito

Com que frequência se preocupa em parecer pouco musculoso(a)? ( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Às vezes ( ) Frequentemente ( ) Sempre

Já deixou de comparecer a compromissos por insatisfação com o corpo? ( ) Sim ( ) Não

Bloco V — Percepção de riscos e efeitos à saúde

Você considera o uso não médico de EAA prejudicial à saúde? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei

Você conhece os possíveis efeitos colaterais dos EAA? ( ) Sim, bem ( ) Parcialmente ( ) Não

Se fez uso, percebeu algum efeito adverso? (pode marcar mais de uma)
( ) Cardiovascular ( ) Hepático ( ) Hormonal/reprodutivo ( ) Psicológico/humor ( ) Nenhum ( ) Não se aplica

De onde vem a maior parte das suas informações sobre EAA? ( ) Profissional de saúde ( ) Educador físico ( ) Internet/redes sociais ( ) Amigos ( ) Outro: _____

Bloco VI — Relação com o profissional de Educação Física

Algum profissional de Educação Física já conversou com você sobre os riscos do uso de EAA? ( ) Sim ( ) Não

Você se sentiria à vontade para falar sobre o uso de EAA com o seu professor? ( ) Sim ( ) Não ( ) Talvez

Na sua percepção, qual deve ser a postura do educador físico diante do uso de EAA? ( ) Orientar sobre riscos e encaminhar ( ) Não interferir ( ) Indicar como usar com segurança ( ) Não sei

Você já recebeu de um educador físico alguma indicação de substâncias ou protocolos de uso? ( ) Sim ( ) Não

Você acredita que o exemplo do profissional (uso ou não de EAA) influencia os alunos? ( ) Sim ( ) Não ( ) Em parte

Bloco VII — Comentários (opcional)

Espaço livre para observações que você julgue relevantes sobre o tema:

_____

_____

Agradecemos a sua participação.

APÊNDICE B – MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

(instrumento proposto, não aplicado nesta pesquisa)

Nota: este instrumento é apresentado como proposta para eventual aplicação futura em pesquisa de campo, condicionada à prévia submissão e aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Não foi aplicado no presente estudo, de natureza de revisão.

Título da pesquisa: Uso de esteroides anabolizantes por praticantes de musculação e o papel do profissional de Educação Física: entre a orientação e a conivência.

Instituição: UNIFACS — Universidade Salvador. Curso: Educação Física (Bacharelado).

Pesquisadores responsáveis: Hugo Ferreira dos Reis; Joilson Moura dos Santos Fortuna; Albert Aelcio Dias da Silva. Orientador: Prof. Dario da Silva Monte Nero.

Você está sendo convidado(a) a participar, de forma voluntária, da pesquisa acima identificada. Antes de decidir, leia com atenção as informações a seguir. Este documento, elaborado em conformidade com a Resolução CNS nº 466/2012 e a Resolução CNS nº 510/2016, esclarece os objetivos, os procedimentos, os riscos e os benefícios do estudo, bem como os seus direitos como participante. Em caso de dúvida, pergunte ao pesquisador antes de consentir.

1. Objetivos do estudo

O estudo busca analisar o papel e os limites éticos do profissional de Educação Física diante do uso de esteroides anabolizantes por praticantes de musculação em academias.

2. Procedimentos

Caso aceite participar, você responderá a um questionário anônimo e autoaplicável, com perguntas sobre seu perfil, seus hábitos de treino, o eventual uso de EAA, suas motivações e sua percepção sobre o tema. O preenchimento leva, em média, de 10 a 15 minutos. Não serão solicitados nome, documentos ou quaisquer dados que permitam a sua identificação.

3. Riscos e desconfortos

A pesquisa envolve riscos mínimos. É possível que algumas perguntas, por tratarem de um tema sensível, causem constrangimento ou desconforto emocional. Você poderá deixar de responder a qualquer pergunta que não desejar e interromper a participação a qualquer momento. Caso sinta necessidade, poderá ser orientado(a) quanto à busca de apoio em serviços de saúde.

4. Benefícios

Não há benefício direto e imediato pela participação. Os benefícios são indiretos e coletivos, decorrentes da ampliação do conhecimento sobre o uso de EAA e sobre o papel ético do educador físico, com possível contribuição para ações de prevenção e para a formação profissional.

5. Sigilo, anonimato e uso dos dados

Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para fins acadêmico-científicos (elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, publicações e apresentações). Como o questionário é anônimo, não será possível vincular as respostas a nenhum participante. Os resultados serão divulgados de forma agregada, sem qualquer identificação individual. Os dados serão armazenados de forma segura pelos pesquisadores pelo período mínimo de 5 (cinco) anos e, após esse prazo, serão descartados, em observância à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

6. Participação voluntária e direito de retirada

A sua participação é inteiramente voluntária. Você tem o direito de recusar-se a participar ou de retirar o seu consentimento a qualquer momento, sem necessidade de justificativa e sem qualquer prejuízo ou penalização. Ressalta-se, contudo, que, por se tratar de instrumento anônimo, após a entrega do questionário preenchido não será possível identificar e retirar as respostas já fornecidas.

7. Ressarcimento e indenização

A participação não implica qualquer custo nem remuneração. Como o preenchimento ocorre no próprio local da academia e não gera despesas ao participante, não há previsão de ressarcimento. Fica assegurado, nos termos da legislação vigente, o direito à indenização diante de eventuais danos comprovadamente decorrentes da pesquisa.

8. Contatos

Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, entre em contato com os pesquisadores responsáveis pelo e-mail e telefone fornecidos. Dúvidas sobre aspectos éticos podem ser encaminhadas ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFACS. O CEP tem a função de defender os interesses dos participantes, respeitando seus direitos, e contribuir para o desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.

_____

Assinatura do(a) participante

_____

Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável

Observação: por se tratar de questionário anônimo, caso o Comitê de Ética em Pesquisa autorize a dispensa de assinatura para preservação do anonimato, o consentimento poderá ser manifestado pela assinalada concordância no cabeçalho do questionário, mediante entrega ao participante de uma via deste Termo para guarda.

ANEXO A – RESOLUÇÃO CONFEF Nº 508/2023

Código de Ética Profissional do Sistema CONFEF/CREFs

O texto integral da Resolução CONFEF nº 508/2023 — Código de Ética Profissional do Sistema CONFEF/CREFs — encontra-se disponível no sítio oficial do Conselho Federal de Educação Física (https://www.confef.org.br). Acesso em: 21 set. 2026.